Apuntes

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL: SALUD

tania.seoane@mail.udp.cl

Clase 03

20/08

John Graunt (1620-1674)

- Fundador de la demografía
- Evidenció relaciones estadísticas entre mortalidad y condiciones de vida

Ilustración y Revolución Industrial

- Mejoras en la agricultura crearon mayor productividad y mejor nutrición.
  - Se asocia a mayores tasas de natalidad y menores tasas de mortalidad, produciendo un rápido crecimiento de la población.
  - Las ciudades sobrepobladas estaban mal equipadas para abastecer a la clase trabajadora.
- En 1700, Bernardino Ramazzini publicó Enfermedades de los Trabajadores, aplicando principios de epidemiología.

James Lind (1716-1794)

- El escorbuto (muerte negra del mar) era un problema de salud fundamental entre navegantes, especialmente durante viajes largos
  - Enfermedad de desnutrición debido a falta de vitaminas, se puede ver en fatiga, manchas, etc.
- En 1747, Lind llevó a cabo un estudio tratando a 12 marinos que presentaban síntomas de escorbuto.
  - Les dio uno de seis regímenes nutricionales, los dos marinos alimentados con naranjas y limones se recuperaron en 6 días.
  - Considerado el primer ensayo clínico en investigación epidemiológica
- Las vitaminas

Edwar Jenner (1749-1823)

- La viruela, una enfermedad devastadora, había sido reconocida desde el siglo III A.C.
  - Tasas de mortalidad entre 25% y 40%, también asociada a severas secuelas

- Jenner investigó creencias populares de que las ordeñadoras eran inmunes a la viruela por su exposición a la viruela del ganado.
- Tomó viruela del ganado de una ordeñadora y la aplicó a un niño, quien obtuvo inmunidad.
- En 1977 se identificó el último caso de viruela en el mundo. En 1980 la OMS declaró su erradicación.
    - Mayor logro de la historia de la salud pública.
    - No desapareció, solo que no andaba libre (al no tener humanos libres para hospedar).

Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872)

- Fundador de la epidemiología moderna.
- Desarrollo el "método numérico", que implicaba el uso de promedios de grupos de pacientes para determinar lo que se debía hacer con pacientes individuales
    - Enfatizaba la importancia de la similitud entre pacientes más allá del diagnóstico.
- Descubrió que la sangría no era efectiva.

John Snow (1813-1858)

- Una gran pandemia de cólera se originó en India entre 1825 y 1854 y se extendió producto de mejoras en el transporte a Europa y Norteamérica.
- Snow investigó un brote de cólera en Londres en 1854.
    - Se enfocó en 500 muertes ocurridas durante 10 días.
    - Las personas infectadas viven cerca de una bomba de agua.
    - Las personas que usaban alguna de un pozo no se contagiaron.
    - Snow persuadió a las autoridades para quitar la manida de la bomba y el brote desapareció en unos pocos días.
    - Posteriormente Snow investigó otro brote, determinando con precisión que ciertas compañías de agua proveían a las personas afectadas.
    - Pasa a ser una pandemia cuando la transmisión ocurre entre locales.
    - Más de un continente + transmisión entre locales = pandemia.

Peter Ludvig Panum (1820-1885)

- Enviado a las Islas Feroe por el gobierno danés para investigar un brote de sarampión
- Panun visitó todos los rincones de las islas, investigando la cadena de transmisión entre distintos lugares, así como la inmunidad de personas expuestas.
- Concluyó que el sarampión es una enfermedad contagiosa…

Ignacio Semmelweis (1818-1865)

- Las muertes de mujeres atendidas por personal médico durante el parto eran 2 a 5 veces

más frecuentes que las mujeres atendidas por matronas.
- Semmelweis supuso que esto se debía a que los médicos realizan una autopsia antes de atender un parto.
- Exigiendo la desinfección de las manos posterior a las autopsias, logró reducir la tasa de mortalidad a los niveles del grupo atendido por matronas
    - Sin embargo, sus ideas no fueron aceptadas por la comunidad media y terminó muriendo en un manicomio. La desinfección de manos….

Teoría de los gérmenes

- Basada en medicina grecorromana postulaba que la enfermedad era el resultado de emanaciones ambientales o miasmas (vapores nocivos provenientes de la suciedad).
    - Método de prevención:

Teoría de los miasmas

- A

Postulados de Koch (1843-1910)

- El agente patógeno debe estar presente en cada caso de la enfermedad en las condiciones apropiadas y ausente en las personas sanas.
- El agente no debe aparecer en ninguna otra enfermedad de manera fortuita.
- El agente debe ser aislado del cuerpo en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad.
- El agente debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado.
- El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación

Florence Nightingale (1820-1910)

- Fundadora de la enfermería.
- Sirvió como entrenadora de enfermeras en la Guerra de Crimea (1853-1856), organizando el cuidado de los soldados.
- Fue reconocida en la cultura popular como la “Lady with the Lamp” que hacía rondas cuidando a los soldados por la noche.
- Se dedicó al estudio de la estadística y la epidemiología y fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society.
- A

Jean Henri Dunant (1828-1910)

- En 1859, presenció las consecuencias de la batalla de Solferino.
- Alrededor de 38.000 soldados heridos, agonizantes y muertos permanecían en el campo

de batalla.

- Dunant organizó

Siglo XX

- **Descubrimiento de vacunas para poliomielitis**
  - América libre de polio en 1990.
  - Europa libre de polio en 2002.
  - India libre de polio en 2014.
  - La erradicación mundial se anticipa para el 2015, pero aún hay casos en Pakistán, Nigeria y Afganistán. En 2014 se declara emergencia internacional por nuevos casos en ondas no endémicas de África.
- Dengue endémico de la Isla de pascua **(Pregunta de prueba)**
- **Pandemia de SIDA**
  - Primeros casos detectados en 1981.
  - Identificación del VIH en 1984.
  - Las tasas globales de nuevas infecciones y muertes asociadas. comienzan a disminuir en la segunda década del s. XXI.
  - El PEP, siempre es bueno tomarlo.

Joseph Goldberg

- La pelagra, a menudo confundida con la lepra, era considerada una enfermedad infecciosa.
- Goldberg visitó hospitales psiquiátricos y orfanatos con números casos y se percató de que los funcionarios no presentaban la enfermedad
- Modelo asilar

Transición Epidemiológica

- Durante mitad del siglo XX las enfermedades infecciosas predominan como causas de muerte, incluso en países desarrollados
- Desde la 2° Guerra Mundial ha ocurrido un cambio sustancial en los patógenos epidemiológicos en países industrialización
  - Enfermedades asociadas al estilo de vida: enfermedades cardiovasculares, cáncer pulmonar, obesidad, adicciones, entre otras.
- Estos problemas de salud resultan más complicados que las enfermedades infecciosas, pues puedo vacunar a alguien contra un virus pero no en contra de una mala nutrición por ejemplo, tanto respecto de su casa de su abordaje
  - Recordar que la salud está mediada por los determinantes sociales, no es solo por decisión.

Globalización de la salud pico pal q lee

- La cooperación internacional ha sido parte de la diplomacia desde la primer conferencia internacional sobre cólera en 1851 en El Cairo
- Establecida en 1948, La OMS sostiene en su acta constitutiva que la salud es “un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no únicamente la ausencia de enfermedad”
    - Bajo el liderazgo de la OMS, la viruela fue erradicada en 1977, demostrando que problemas globales de salud pública pueden ser controlados a través de la cooperación internacional
- Amenazas de la salud salud pública pueden emerger y extenderse rapdiamete com en el caso del VIH en los 80s, El SRAG en 2003 o el COVID 19 en la actualidad
- Los problemas de salud globales están, por definición, más allá de las capacidades de países individuales o incluso grupo de países
    - El problema de alimentación de África o del problema de la basura

Logros de la salud pública en el siglo XX

- Control de enfermedades infecciosas
- Vacunación masiva
- Mayor seguridad en vehículos motorizados
- Mayor seguridad en lugares de trabajo
- Mayor seguridad en la producción y manipulación de alimentos
- Disminución en muertes por enfermedad coronaria
- Mejoras en el cuidado de recién nacido y sus madres
- Planificación familiar - planificar lo sexoreproductivo
- Fluoración del agua potable
- Disminución en el consumo de tabaco

pico PAL q lee jiji

Bloque 2 - Presentación de casos de salud

Es importante aprender a presentar casos de salud, la clase es integrar lo aprendido en una comprensión coherente de la salud, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico clínico

Estructura de la presentación de caso de Salud

1. Datos generales
   - ➢ Genograma y su descripción biopsicosocial
   - ➢ Ecomapa
   - ➢ Tipología psicosocial de la enfermedad y fase temporal
   - ➢ Descripción general del proceso de afrontamiento y ajuste de la enfermedad
2. Descripción general de la enfermedad
   - ➢ Definición de la población a intervenir
   - ➢ Epidemiología
   - ➢ Criterios Diagnósticos
   - ➢ Tratamientos frecuentes
   - ➢ Evidencia de intervenciones familiares (PICOT)
3. Proceso de atención
   - ➢ Tipos de atención con el paciente y sus familiares o red cercana

Genograma: *Permite mapear como la familia organiza la enfermedad*

Es una herramienta para analizar la enfermedad en el contexto relacional y familiar

Desde la psicología de la salud: La enfermedad está influida por:

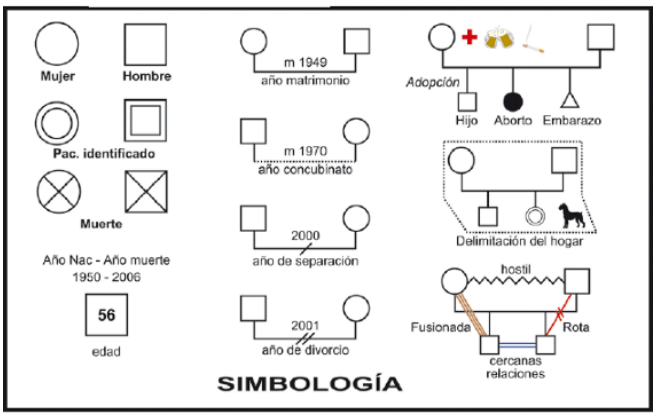
- ❖ Vínculos
- ❖ Historia familiar
- ❖ Formas de cuidado

La enfermedad impacta a toda la familia y se organiza según:

- ❖ Tipo de enfermedad
- ❖ Momento del ciclo vital
- ❖ Recursos familiares

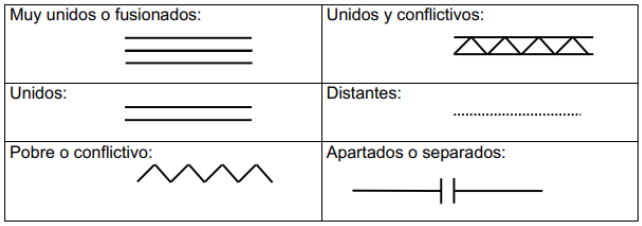
Pasos del genograma

1. Define al paciente índice
   - ➢ Es la persona central del caso
   - ➢ Se marca con doble círculo o doble cuadrado

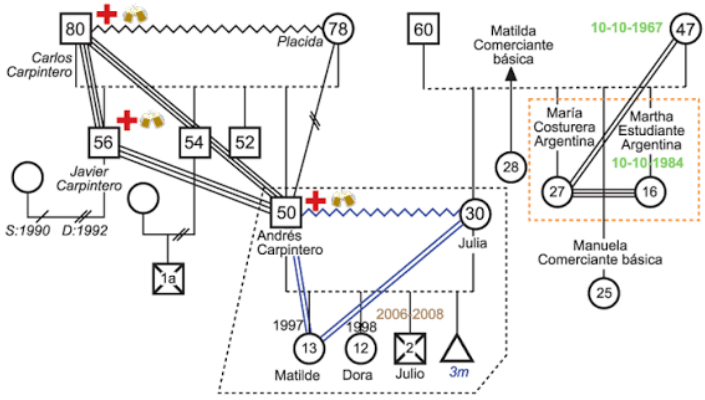


- ➢ Se ubica en el centro del genograma

2. Levanta la estructura familiar
   - ➢ Incluye al menos: abuelos, padres, hermanos, tíos, etc.
3. Agrega información relevante de salud (y todo grupo familiar)
   - ➢ Incluye:
     - Edad
     - Enfermedades
     - Diagnóstico Psiquiátricos
     - Causa de muerte (si aplica)
     - Ejemplo: “Padre, 58 años, alcoholismo”, “Madre, 52 años, depresión recurrente”
4. Incorpora la calidad de las relaciones (clave clínicamente)
   - ➢ Usa líneas en personas
     - Líneas continuas - relación cercana
     - Línea doble - Muy cerca / fusionada
     - Línea discontinua - distant
     - línea zigzag- conflictiva
     - Línea cortada
5. Agrega eventos significativos
   - ➢ Ejemplos
     - Divorcios
     - Migraciones
     - Muertes
     - Enfermedades graves
     - Crisis económicas
   - ➢ Esto permite entender el contexto del malestar



❖ Ejemplo de genograma:



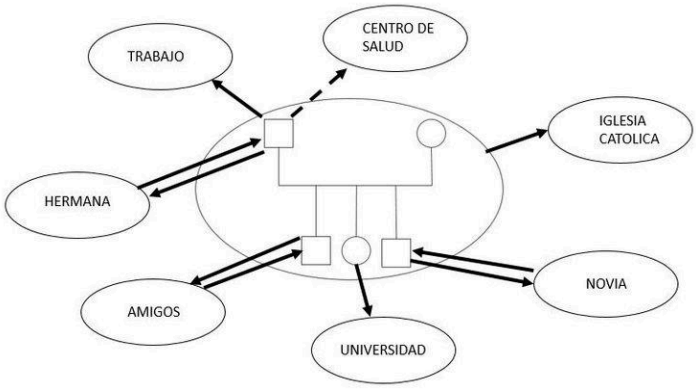
Ecomapa

El ecomapa permite ver si el paciente está sostenido por su entorno o sobrecargado por él, lo que es central para comprender su proceso de salud-enfermedad.

Es la representación gráfica de la relación entre una persona o familia y su entorno, es decir, cómo se vincula con sus distintos sistemas/redes (salud, trabajo, escuela, comunidad, redes de apoyo). Permite visualizar las que existen y cómo son esos vínculos (si son de apoyo, tensos,

débiles o inexistentes)

- ➢ Permite
    - Comprender el contexto social de la enfermedad.
    - Identificar redes de apoyo reales.
    - Detectar fuentes de estrés o sobrecarga.
    - Analizar el acceso a sistemas de salud.
    - Evaluar factores protectores y de riesgo en el entorno.



Ejemplo:

- ➢ *Líneas según que tanto nutre "ella nutre su relación con la U pero la U no la nutre a ella"*

<u>Pasos para construir un ecomapa</u>

1. Definir el sistema central
    - Dibujar al paciente o familia en el centro de un círculo.
    - Ejemplo: "mujer, 35 años, con diagnóstico de depresión".
2. Identificar sistemas externas relevantes:
    - ubicar según sus distintas relaciones
    - ej: Cesfam, Parja, amigos etc
3. Representar cada sistema como un círculo periférico
    - Distribuirlos alrededor del sistema central
    - Ejemplo: "trabajo" "madre" "psiquiatría" "amia"
4. Dibujar las conexiones
    - Unir el centro con cada sistema usando líneas.
    - Ejemplo: línea hacia la madre, hacia abajo o bidireccional.
5. Identificar calidad del vínculo
    - Línea gruesa - apoyo fuerte
    - Línea delgada - débil
    - Línea zigzag - conflictivo
6. Agregar dirección del flujo (si aplica)
    - Flechas para indicar si el apoyo es mutuo o unilateral
    - Ejemplo: paciente cuida a la madre pero no recibe apoyo
7. Incorporar información relevante
    - Breves descripciones del vínculo
    - Ejemplo: "jefe exigente", "amiga contenedora"
8. Lectura clínica del ecomapa
    - Analizar:

        - ¿dónde están los apoyos?
        - ¿Dónde está la sobrecarga?
        - ¿Qué redes faltan?
    - Ejemplo: alta carga en rol de cuidadora + bajo apoyo social = factor de riesgo para depresión

Tipología psicosocial de la enfermedad de John Rolland 1987

Es una (la mejor) forma de clasificar las enfermedades desde la visión psicosocial, el impacto social y psicológico que tienen las enfermedades en las personas (no solo lo biomédico)

Permite al psicólogo:

- ➢ Anticipar tipos de reacción emocional (shock, negación, desgaste, etc)
    - Reacción es distinta a una diabetes que a un enfermedad mortal
- ➢ Comprender dinámicas familiares esperables.
- ➢ Ajustar intervenciones según el tipo de enfermedad.
- ➢ Evitar intervenciones "genéricas" que no calzan con la experiencia del paciente.

John Rolland

Rolland propone entender que no todas las enfermedades general el mismo tipo de crisis, ni exigen las mismas adaptaciones

- ➢ "El tipo de enfermedad y su curso temporal configuran diferentes demandas adaptativas para los pacientes y sus familias"
- ➢ "cada fase implica tareas psicosociales específicas que requieren distintas formas de afrontamiento "
- ➢ "El significado de la enfermedad para el paciente y la familia es tan importante como sus características médicas"
    - Mucha importancia el cómo se siente estar enfermo, más allá de los síntomas, como el y la familia siente el enfermar
- ➢ En cada etapa se hacen cosas, en cada enfermedad se hacen distintas cosas,en cada familia se hacen distintas cosas.

Dimensiones principales de la tipología

1. Forma de inicio chimichurri- conita y tus lentes
    - Agudo: aparece bruscamente (infarto, accidente)
        - Genera crisis intensa, desorganización inmediata.
    - Gradual o Insidioso: aparece lentamente (diabetes, hipertensión)

        - Adaptación progresiva, a veces negación o minimización.
2. Curso / evolución
    - Progresivo: Empeora con el tiempo *(demencia)*
        - mayor carga emocional y desgaste
    - Constante: se mantiene estable *(como la hipertensión)*
        - permite cierta organización de la vida
    - Recurrente/episódico: crisis y remisiones
        - Incertidumbre, ansiedad anticipatoria
        - Ejemplo: asma *(no es estable pues le dan crisis),* trastorno bipolar, resfriado.
    - La adaptación es importante, y define incluso el curso y evolución (ejemplo una actitud de negación complejiza y puede determinar el curso)
    - El curso ya me dice que problemas pueden venir (demencia es progresiva e indica mayor carga)
3. Consecuencias
    - No incapacitante: permite funcionalidad
    - Incapacitante: limita autonomía pico pal que lee. 2 veces
    - Potencialmente fatal: confronta con la muerte
    - Aquí aparece fuerte impacto en:
        - Identidad
        - Proyecto de vida
        - Dependencia v/s autonomía
    - Depende del momento de la enfermedad, obvio si esta aguda será incapacitante, pero luego no (diabetes controlada por ejemplo)
4. Grado de incertidumbre (de padecer la enfermedad y de el curso)
    - Alta incertidumbre: más ansiedad, hipervigilancia.
    - Baja incertidumbre: mayor sensación de control.

Dimensiones principales de las **fases temporales** de la enfermedad

Describe el momento del proceso de enfermedad en que se encuentra la persona/familia que cada fase implica tareas emocionales distintas

Permite al psicólogo:

- ➢ Intervenir de forma oportuna y pertinente
- ➢ No exigir procesos emocionales que aún no pueden ocurrir
- ➢ Acompañar las tareas psicológicas propias de cada etapa

"La enfermedad no es solo un evento biológico, es una experiencia psicosocial situada en el tiempo, comprender su tipología y su fase nos permite acompañar a los síntomas y a los procesos humanos"

1. Fase de crisis (inició/diagnóstico)

➢ Shock, negación, miedo, confusión
- Alta intensidad de información y contención

➢ Tarea psicológica
- Procesar la noticia
- Restablecer un mínimo de control
- *Ejemplo: paciente recién diagnosticada con cáncer de mamá teniendo un hijo de 8 meses*

2. Fase crónica (adaptación)
- La enfermedad se integra a la vida cotidiana
- Aparecen:
  - Fatiga emocional
  - Ajustes familiares
  - Cambios en roles: de cuidador a ser cuidado ejemplo.
- Tarea psicológica:
  - Reorganizar la vida
  - Construir una "nueva normalidad"

3. Fase terminal (si aplica)
- Conciencia de fin de vida
- Procesos de duelo anticipado
  - Duelo comprendido a la pérdida, no solo de la persona enferma, sino que también de la vida anterior, la expectativa de futuro, etc.
- Tarea psicológica:
  - Elaboración emocional
  - Cierre de ciclos
  - Trabajo con la familia

No es lo mismo una enfermedad aguda reversible en fase de crisis a una enfermedad progresiva en fase crónica. Por qué cambia…

➢ La vivencia subjetiva
➢ La respuesta familiar
➢ El tipo de intervención socióloga

<u>Ciclo Vital Familiar</u>

Es la secuencia de las etapas por las que atraviesa una familia a lo largo del tiempo, donde cada fase implica:

➢ Tareas evolutivas

- ➢ Cambios en roles
- ➢ Desafíos emocionales y relacionales

¿Para qué sirve en psicología de la salud?

- ➢ Permite:
- ➢ Entender cómo impacta una enfermedad según el momento vital
- ➢ Identificar crisis normativas v/s no normativas
- ➢ Ajustar intervenciones al contexto familiar

<u>Etapas del ciclo vital</u>

1. Formación de la pareja
    - Unión de dos historias familiares
    - Construcción de intimidad y acuerdos
    - Tarea clave:
        - Diferenciación de familias de origen
        - Creación de un “nosotros”
2. Familia con hijos pequeños
    - Llegada de los hijos
    - Reorganización de roles (cuidado, trabajo, tiempo)
    - Tarea clave:
        - Adaptarse a la parentalidad
        - Integrar al hijo sin perder la pareja
3. Familia con hijos en edad escolar
    - Apertura al mundo social (colegio, normas externas)
    - Tareas clave
        - Socialización
        - Equilibrio entre control y autonomía
4. Familia con hijos adolescentes
    - Búsqueda de identidad de los hijos
    - Mayor tensión y negociación
    - Tarea Clave:
        - Flexibilizar límites
        - Acompañar la individuación
5. Plataforma en lanzamiento (hijos que se van)
    - Salida progresiva de los hijos del hogar
    - Tarea clave:
        - Reorganizar la pareja
        - Elaborar el “nido vacío”
6. Familia en etapa media (pareja madura)
    - Reencuentro de la pareja

        - Cuidado de padres envejecidos (doble vía)
        - Tareas Clave
            - Redefinir proyectos
            - Afrontar Envejecimiento
7. Familia en etapa tardía
    - Jubilación, pérdidas, cercanía de la muerte
    - Tarea clave:
        - Elaboración de duelos
            - Redefinición de la identidad (importante evitar hacerlo desde la carencia).
        - Transmisión de legado

<u>Proceso de afrontamiento y ajuste de enfermeda</u>

El ajuste a la enfermedad no depende solo de la persona sino de cómo el sistema se reorganiza en relación a su momento vital, su estructura y sus recursos.

El ajuste a la enfermedad depende de:

- ➢ Cuándo ocurre (ciclo vital)
- ➢ Cómo se reorganiza la familia (estructura)
- ➢ Con qué herramientas cuenta (recursos)
- ➢ Quiénes sostienen el proceso (redes)

Variables

1. Uso de recursos
    - ¿Qué mirar? Recursos internos del individuo y la familia
    - Tipos:
        - Emocionales: regulación, tolerancia al malestar
        - Cognitivos: formas de interpretar la enfermedad
        - Conductuales: adherencia, autocuidado
    - Ejemplos:
        - Afrontamiento activo v/s evitativo (etapas)
            - *Es una forma de afrontamiento evitativo: el evitar hacerse cargo de la resolución*
            - *Afrontamiento evitativo (pasivo) busca elaborar el problema reconocer el problema y buscar recursos, y realizar una distancia del problema, es muy necesario para poder pasar al afrontamiento positivo, en donde se busca un la resolución*
            - *En algún momento es necesario pasar por el afrontamiento*

evitativo
    - *A algunas personas por sus recursos no les es necesario pasar por el afrontamiento evitativo.*
        - Uso de habilidades (ej: DBT en regulación emocional)
    - Clave clínica: No es solo “tener recursos” sino que es saber activarlos
2. Redes de apoyo
    - ¿Qué mirar? apoyo social disponible y efectivamente utilizado
    - Tipo de red
        - Familiar extendida
        - Amigos
        - Equipos e saud
        - Comunidad
    - Riesgos
        - Aislamiento
        - Dependencia excesiva
        - Apoyo invasivo o poco ajustado
    - Clave clínica: la red no solo debe existir, debe ser funcional y pertinente
3. Etapa del ciclo vital familiar
    - ¿Qué mirar? Momento evolutivo en que ocurre la enfermedad.
    - ¿Por qué es clave? Porque define:
        - Expectativas de vida
        - Tareas pertinentes
        - Impacto subjetivo
    - Ejemplos:
        - Enfermedad en familia con hijos pequeños → afecta el cuidado y dependencia
        - Enfermedad en etapa tardía → se integra más a la finitud
    - Clave clínica: la misma enfermedad tiene significados distintos según la etapa
4. Ajustes en la estructura familiar
    - ¿Qué mirar? Cambio en roles, jerarquías y funciones
    - ¿Qué suele ocurrir?
        - Redistribución de tareas (quién cuida, quién trabaja)
        - Inversión de roles (hijos que cuidan padres)
        - Sobrecarga en un miembro
    - Riesgos
        - Rigidez: no cambiar ese a la crisis
        - Caos: desorganización total
    - Clave clínica: el ajuste saludable implica flexibilidad estructural

Búsqueda de evidencia con Pregunta PICOT

Es una estrategia para formular preguntas clínicas bien estructuradas de una enfermedad o problema en salud, que permite buscar evidencia científica de forma más rápida, precisa y útil.

Se usa mucho en medicina basada en evidencia y en psicología de la salud

¿Para qué sirve como “motor de búsqueda”?

- Funciona como un filtro inteligente
  - Evia búsquedas vagas en bases de datos
  - Ordena lo que realmente quieres saber
  - Mejora la calidad de artículos que encuentras
- Paso a paso
  - Identificar el problema clínico
  - Completar cada letra de a palabra PICOT

PICOT

- P = paciente o problema
  - ¿En quién estás pensando? ej: adultos con depresión
- I = Intervención
  - ¿Qué quieres evaluar? ej: tcc
- C = Comparación
  - ¿Con qué lo comparas? (opcional) ej: farmacoterapia
- O = outcome/resultado
  - ¿Qué quieres lograr o medir? ej: Disminución de síntomas
- T = Tiempo
  - ¿En cuanto tiempo? ejemplo: 3 meses

“En adultos con depresión (P), la TCC (I) comparada con fármacos (C), reduce los síntomas (o) en 3 meses (T)?”

- Esto se traduce en mejores palabras claves para buscar en:
  - PubMed
  - Scielo
  - Google Scholar

Clase 04

27/08

Vulnerabilidad Social y Salud Pública

Los autores hablan de vulnerabilidad y no vulneración, porque no es propia del sujeto, es un espacio que el sujeto habita, donde el sujeto fue puesto en ese espacio.

Concepto de Vulnerabilidad

- ★ Fenómeno multidimensional, dinámico, que expone a la persona a un aumento del riesgo de incurrir en un daño o error por parte de otro.
- ★ Razones que justifican introducir en la organización social, y en concreto, en los sistemas de derecho, un trato diferenciado para aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad cuya causa es una desigualdad material injusta o arbitraria en relación a un colectivo mayor.
- ★ Resultado de exposición a riesgos (eventos, características y procesos), incapacidad para hacerles frente, ya sea por mecanismos personales internos o apoyo externo (recursos económicos, protección social, redes de apoyo y herramientas individuales) e inhabilitado para adaptarse activamente a sus consecuencias (PPT)
- ★ Incapacidad, temporal o permanente, individual o grupal, para realizar una evaluación adecuada de la relación riesgo beneficio, y por tanto, de dar un consentimiento informado válido para participar en una investigación científica determinada.
- ★ Rescatar la dimensión social de la vulnerabilidad como una construcción socio-cultural histórica, señalando que hay personas, poblaciones y espacios vulnerables dado los riesgos que experimentan por la pérdida de poder y control, relevando el rol de la distribución del poder entre hombres y mujeres en la generación y mantención de la violencia de género.
- ★ Es necesario introducir las condiciones políticas, económicas, físicas y sociales que exponen a las personas y grupos a un mayor o menor riesgo frente a las amenazas naturales determinando el nivel de daño.

<u>¿Somos vulnerables?</u>

- ★ ¿Tenemos características que nos hagan ser vulnerables?
- ★ ¿Hemos tenido experiencias donde queda en evidencia o seamos conscientes de nuestra vulnerabilidad?
- ★ ¿Hemos experimentado alguna vulnerabilidad en nuestro acceso a la salud?
    - ○ *Nuestro acceso a la salud está determinado por el espacio de vulnerabilidad que habitamos.*
    - ○ *Ej: necesitar medicamento pero no poder pagarlo.*
- ★ ¿Nos preocupan situaciones de vulnerabilidad potenciales o futuras?

- ★ Inherente del ser humano
  - Resultado de la fragilidad humana y por ende intrínseca del ser humano
- ★ Dinámica
  - Las vulnerabilidades van cambiando a lo largo de la vida, en el tiempo y también en los distintos contextos, comunidades y territorios.
- ★ Multidimensionalidad
  - Las dimensiones posibles con los peligros internos del grupo, los peligros externos y la capacidad de afrontamiento a estos peligros. Asimismo hay otras dimensiones como el grupo etario, discapacidad, género, territorio.
- ★ Multinivel
  - Ocurre a nivel individual, de hogar, comunidad y sociedad.
- ★ Compleja
  - Es el resultado de la interacción de múltiples factores que en el tiempo se acumulan, suman, atenúan y mitigan.
- ★ Relacional
  - Parece un componente que surge de la inequidad en la distribución del poder, resultando en dsicriminacion, marginalidad y exclusión social.
- ★ Acumulativa en el momento y el tiempo
  - Los tipos de vulnerabilidad se suman y acumulan en un mismo momento, así como se van acumulando en el tiempo en función de un deterioro de la capacidad de respuesta y causas estructurales y ambientales persistentes.
  - *Ej: infante que sufrió bullying, le afectara en su desempeño en la universidad*
- ★ Transmisible de una generación a otra
  - Se describe una transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad, a través de mecanismos como la violencia, el trauma, la pobreza y la exclusión social.
- ★ Modificable
  - Las personas y grupo sociales, caen en situaciones de vulnerabilidad, pero también es posible salir de esta condición en base a la capacidad de respuesta, las modificaciones del ambiente y el apoyo de otros y el estado.

Pobreza

De acuerdo a la OMS (1995), la pobreza extrema es “el asesino más despiadado del mundo y la mayor causa de sufrimiento en la Tierra”.

- ★ Impacto directo en la salud
  - Menor acceso a servicios de la salud
  - Opinions limitadas e tanto al estilo de vida
  - Discriminacion, abuso y
  - PPT
  -

-

Gráfico ppt

Considerar fortalezas dentro de la vulnerabilidad (estudio que habla de esto)

- ★ Es importante mantener una perspectiva balanceada que no se enfoque solamente en el modelo del déficit.
- ★ Sesgo en la literatura tradicional:
  - Definición como conductas “normales” las que poseen mayormente personas de clases económicamente estables, definiendo cualquier diferencia como patológico o problemático.
- ★ Las personas en situación de pobreza desarrollan respuestas psicológicas adaptativas frente a sus circunstancias así como fortalezas que aumentan sus habilidades
  - Mayor rapidez en la detección y respuesta ante amenazas inmediatas
  - Flexibilidad cognitiva para operar en contextos caóticos o cambiantes
  - Agudeza por la resolución de problemas en condiciones de estrés y escasez
- ★ Implica **NO** “”romantizar” la pobreza, pero tampoco hablar solo desde el déficit (muy dicotómico)
- ★ No invisibilizar los costes reales de la pobreza
  - Búsqueda de integración entre modelos de déficit y “optimistas” para la conformación de intervenciones más efectivas y menos estigmatizantes.

Inequidad de ingresos

- ★ El coeficiente de gini desarrollado por corrado gini, en 1912 e la razón entre areatzA y A+B en al curva de lorenz
- ★ En el gráfico, la diagonal recta representa una igualdad perfecta, en donde cada porcentaje de la población acumula exactamente la misma proporción de los ingresos generados en el economía
- ★ La curva de Lorenz (la lieba de ia curva) refleje la realidad
- ★ El coeficiente de Gini es simplemente

En Chile. (ppt)

- ★ En 2024 gini está en 0.43 tendencia a bajada del coeficiente, y más acercamiento a la equidad de los ingresos

Inequidad Global (ppt)

- ★ Existen países que se enriquecieron mucho y otros países que se empobrecieron o que mantuvieron su estabilidad.

- ★ En 1970 en adelante fue bajando
- ★ Las barras amarillas es lo que sucede entre naciones, la inequidad entre naciones va hacia abajo, pero las baras es la inequidad dentro de los propios países va aumentando
    - ¿Los países de más recursos, tienen mejor salud que los países más bajos? no necesariamente, porque depende de la distribución de los recursos, ejemplo EEUU la inquietud refleja una mala gestión de los recursos de salud
    - Distribución de los recursos es lo que determina la calidad de la salud
    - A mayor brecha, peor salud

Inequidad en LATAM (ppt)

- ★ Latam con mayor inequidad.
- ★ Una de las grandes críticas a este studios de inequidad es que se hacen en base al CENSO (el estado solo preguntara lo que estime) incluso algunos estudios se contradicen

ppt

- ★ La desigualdad socioeconómica produce una doble condena de salud: los sectores de menores ingresos son los que enferman más y peor evalúan su estado de bienestar (F.4) y a la vez, son quienes enfrentan los mayores obstáculos burocráticos y temporales para conseguir atención médica y tratamiento.
- ★ En lugar de que el sistema de salud actúe como un “ecualizador social”, las barreras de acceso terminan perpetuando y profundizando la brecha de inequidad.

Modelo que habla de posición socioeconómica a lo largo del ciclo vital (ppt)

-

Salud en Todas las Políticas

- ★ Definicion OMS: Es un enfoque de políticas públicas a través de los distintos sectores que toma en cuenta sistemáticamente la implicaciones de las decisiones de salud y en los sistemas de salud
    - El enfoque busca sinergias y evitar impactos negativos en salud, de modo de mejorar la salud de la población y la equidad en salud. El enfoque se funda en derechos PPT

Políticas públicas **a secas**

- ★ Son decisiones, acciones, normas y estrategias establecidas por el estado, orientadas a la solución de porelma spunlcios
- ★ Aquellos que argentan el colectivo, ya sean problemas sentidos por la sociedades o problemas potenciales aunque aún no sea de conocimiento del colectivo

- ★ Por ser política:
    - Su origen se centra en el estado
    - Cualquier nivel de gobierno o cualquiera de los poderes públicos
- ★ Por ser pública:
    - Afecta a las comunidades y a la sociedad en su conjunto
    - Se reflejan en: leyes, decretos, resoluciones, reglamentos.

Salud en Todas las Políticas

- ★ PPT
- ★ recien ves los mensajes sonajera
- ★ PEROOOOO
- ★ así son TT
- ★ asi eres tu, descarada me dice que miento…
- ★ MENTIRAAA, se me olvidó verlo antes
- ★ te voy a fumarrrr
- ★ TT
- ★ te voy a acusar a tu mama, y a la espe
- ★ de que te compraste una entrada de 800k
- ★ ???? UDSHKHSKFH así son
- ★ NAAAA
- ★ ERAN 600
    - + lightstick + outfit + weverse
- ★ TT
- ★ Así son TT
- ★ Si igual te faltaron los freebies
- ★ LHFKJDAHJKHJ
- ★ Víctima
- ★ 1 sept 2026 esa es la fecha para el coloquio
- ★ Y la charla de salud mental
    - nada más importante no? DJHSIJHNDJ
    - nop, nada más importante que los estudios Ema, hay que concentrarse en la u

Ejemplos de Políticas Correspondientes a Otros Sectores que Influyen en la Salud

- ★ Asegurar condiciones básicas de vida
    - Agua, higiene, vivienda, infraestructura y servicios básicos
- ★ Aumento de ingreso económico individual y familiar
    - Creación de empleo, aumento de la capacidad productiva y salario mínimo adecuado.

- ★ Sistemas de protección social
    - Protección contra problemas económicos como cesantía y enfermedades catastróficas.
- ★ Apoyo a la participación de la mujer en la economía
    - Cuidado infantil, de los enfermos y ancianos

Mecanismos y estructuras que favorecen la acción integrada

- ★ Leyes y Regulaciones
    - Marcos legales diseñados para fomentar la colaboración internacional o promover políticas de salud.
- ★ Protocolos y acuerdos
    - Acuerdos de colaboración entre instituciones gubernamentales académicas, ongs y empresas.
- ★ Comités interministeriales
    - Compuestos por representantes de distintos sectores (salud, educación, etc).
- ★ Comités de expertos
    - Integrados por expertos de agencias del sector público, instituciones académicas, ongs, sector privado, etc. a menudo son creados en torno a una tasa específica
- ★ Unidades de Apoyo
    - Unidades dentro del ministerio de salud u otros con el mandato de fomentar la colaboración intersectorial.
- ★ MODO ZEN 🧘🧘🧘🧘🧘🧘🧘
- ★ 
- ★ Ministerios de coordinación o fundidos
    - Ministerio con un mandato que incluye distintos sectores o responsables de las coordinación interseccional
- ★ Sistemas de monitoreo y reporte de políticas de salud pública
    - Sistemas o reportes preparados intersectorialmente, con el objetivo de examinar políticas, determinantes y objetivos en salud.
- ★ Evaluaciones de impacto en salud
    - Evaluación de leyes, políticas, regulaciones o programas
- ★ Mecanismos de financiamiento
    - Financiamiento concursable o asignación presupuestaria directa para programas

intersectoriales.





Intervenciones en DM

*"No trabajamos con glucemias, trabajamos con **personas** que tienen una vida donde la **diabetes compite** con muchas otras **cosas**"*

- ★ *Compite con ser mamá, ser hijo, ser trabajador, etc.*
- ★ *"¿Por qué una persona con diabetes, sabiendo lo que le hace mal, igual no sigue el tratamiento?"*
- ★ La adherencia no es falta de información, es un fenómeno **conductual** complejo
- ★ Cognitivo: "no pasa nada si como esto"
- ★ Emocional: frustración, negación.
  - *Existe frustración por las limitaciones, salir del sedentarismo, dejar cosas, etc.*
- ★ Conductual: abandono dieta

Diabetes mellitus

- ★ **Problema central: Alta tasa de no-adherencia**
- ★ Enfermedad crónica
- ★ Requiere auto cuidado constante
  - Alimentación
  - Medicación
  - Monitoreo
  - Ejercicio

Factores psicológicos asociados

Cognitivos	Emociones	Conductuales
Minimización del riesgo Creencias disfuncionales: "igual me voy a enfermar" Pensamiento dicotómico: "o lo hago perfecto o no hago nada"	Negación Rabia Burnout del paciente crónico	Evitación Reforzamiento inmediato (placer v/s salud futura)

TCC y DM

- ★ La adherencia se entiende como: interacción entre pensamiento + emociones + conductas
- ★ Paciente con diabetes frente a comida alta en azúcar
    - Pensamiento:
    - Emoción:
    - Conducta:
    - PPT

Ciclo de mantenimiento: Reforzamiento negativo y positivo

- ★ TCC clave

⬇️

- ★ En diabetes el problema es la conducta

⬇️

- ★ El costo del autocuidado es inmediato (restricción, esfuerzo)

⬇️

- ★ …

Montones, desde TCC

- ★ Psicoeducación conductual
- ★ Registro de pensamientos
- ★ Reestructuración cognitiva
- ★ Resolución de problemas
- ★ Entrenamiento en autocontrol
- ★ Metas graduales (conductas observables)

Técnicas

Técnica 1: Registro ABC

- ★ A: Situación
- ★ B: Pensamiento
- ★ C: Conducta/emoción

Técnica 2: Reestructuración cognitiva (posterior a la técnica 1)

- ★ Identificar pensamiento automático
- ★ Cuestionar (quizás con el método socrático)
    - ¿Es 100% cierto?

        - ¿Qué evidencia tengo?
            - *A favor y en contra*
- ★ Generar pensamiento alternativo

Técnica 3: Micro-metas conductuales

- ★ Ej: “comer sano”, “reducir azucaradas de 7 a 4 por semana”

Técnica 4: Refuerzo

- ★ Reforzar logros pequeños
- ★ Evitar enfoque punitivo

<u>Refuerzo y Micrometas en DM</u>

- ★ En diabetes el problema es estructural
    - El costo del autocuidado es inmediato (restricción, esfuerzo)
    - El beneficio es diferido (evitar complicación futuras)
- ★ Entonces, desde TCC hay que “acercar” la recompensa al presente.
- ★ Sin refuerzo y sin micrometas, la adherencia no se sostiene, porque estás compitiendo contra recompensas inmediatas muy potentes (placer, evitación, alivio).

<u>Micrometas: cómo construirlas bien</u>

- ★ Error Común
    - “Comer sabor”
    - ”Cuidarse más”
    - ”Ser adherente”
- ★ Son metas
    - Abstractas
    - Medibles
    - Emocionalmente abrumadoras

Principios clínicos de la Micro meta

- ★ Conductual (observable)
    - Debe poder verse o medirse
    - ”Tomar bebida sin azúcar 5 días esta semana” v/s “controlar el azúcar”
- ★ Pequeña (ridículamente alcanzable): esto es contraintuitivo pero entra
    - “Caminar 10 minutos 3 veces a la semana” vs “ir al gimnasio todos los días”
    - si la meta no genera resistencia - está bien calibrada
- ★ Específica en contexto
    - “Después de almuerzo, no tomar bebida azucarada en casa” v/s “reducir

azúcar”.

4. gradual (lógica escalera)

- ★ Semana 1 - 2 días
- ★ Semana 2 - 3 días
- ★ Semana 3 - 4 días
- ★ Esto genera autoeficacia y sensación de logro

5. Co-construida (no impuesta) : Si el paciente no la siente propia no se cumple.

- ★ Pregunta clave: “¿Qué cambio pequeño sí sería posible para ti esta semana?
- ★ Si no es snetida acomo propia no la cumplira

Transformar metas grandes en micrometas

- ★ Ejemplo:
- “quiero bajar la glicemia”
- ¿Qué conducta específica influye en eso?
- Bebidas azucaradas

- ★ Micrometa:
- ★ “Cambiar 2 bebidas azucaradas…”

Refuerzo: motor del cambio

- ★ toda conducta que se refuerza, se repite
- ★ El problema en diabetes
  - Comer azúcar-
- ★ Entonces hay que

Tipos de refuerzo

1. Refuerzo positivo externo: agregar ago agradable tras la conducta
- ★ Ej: ver una serie si se cumplió un mes, tiempo personal, pequeños premios.
- ★ Ojo: no comida como recompensa
2. Refuerzo interno (clave a largo plazo): Se entrena activamente
- ★ Ej: “me siento más en control”, “pude hacerlo aunque era difícil”
- ★ El terapeuta ayuda a ser consciente el logro
3. Refuerzo social muy potente

- ★ Ej:
    - Validación del terapeuta
    - Compartir logro con alguien significativo
4. Refuerzo por registro: Progreso = refuerzo visual
- ★ Marcar cumplimiento en calendario
- ★ Apps
- ★ Checklist

Errores frecuentes

- ★ Refinar resultados en vez de conductas:
    - No decir: “Bajaste de peso, bien”
        - Problema: no depende 100% el paciente
    - Mejor decir: ”Lograste cumplir 3 días, eso habla de tu esfuerzo”
- ★ Metas demasiado grandes — fracaso — desmotivación
- ★ Ignorar pequeños logros
    - Esta afecta a la adherencia
- ★ Uso de culpa como “motivación”
    - “Si no te cuidas, te vas a complicar”
- ★ Genera evitación, no cachambi

Integración TCC: como se trabaja en sesión - secuencia clínica

1. Cómo explorar dificultad
- ★ ¿Qué es lo más difícil de seguir la dieta?
2. Detectar obstáculo cognitivo
- ★ ”no tengo tiempo”
3. Ajustar a micrometa
- ★ ¿Qué sería lo mínimo posible?
4. Instalar esfuerzo
- ★ ¿Cómo te pondrías…

Ejemplo Clínico

”El cambio no ocurre por insight ocurre por repetición reforzada de conductas pequeñas”

- ★ ppt
- ★

Actividad: Creación de Micro Metas y Refuerzo en Diabetes

Tarea del terapeuta:

- ★ Reformular la meta del paciente
- ★ Hacerla más pequeña
- ★ Proponer un refuerzo
- ★ Validar dificultad
- ★ ”no intentemos cambiar todo de una vez”
- ★ ”Busquemos algo pequeño que sí sea posible”
- ★ ”¿Cómo podrías reconocerte cuando lo logres?”

El observador marca:

- ★ ¿La meta era específica?
- ★ ¿Era realista?
- ★ ¿Se incluyó refuerzo inmediato?
- ★ ¿Hubo validación emocional?

Clase 05

03/09

Dolor crónico no oncológico

Dolor

Experiencia perceptiva **subjetiva y emocional** desagradable, resultante de factores biológicos, psicológicos y sociales.

- ★ **Nocicepción**: estimulación de los nervios que transportan información sobre daño tisular potencial al cerebro.
- ★ **Dolor**: percepción subjetiva que surge de la transducción, transmisión y modulación de la información sensorial. Está influenciado por factores genéticos, historia previa de aprendizaje, estado psicológico actual y factores socioculturales.
- ★ **Sufrimiento**: Respuestas emocionales desencadenadas por la nocicepción o con algún otro evento relacionado con esta, tales como la depresión y la ansiedad.
    - El sufrimiento de su estado en el que habita un dolor
- ★ **Comportamiento/respuesta al dolor**: Las cosas que hacemos o decimos cuando sufrimos dolor. p. e, evitar ciertas actividades). Comunicación del dolor y el sufrimiento
    - Conducta evitativa, la respuesta más común al dolor

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR

- ★ Según el tiempo
    - Crónico >3 meses
    - Agudo < 3 meses
- ★ Según su etiología u origen

    - **Musculoesquelético**: aparece cuando se lesionan, sobrecarga, inflaman, o irritan los huesos, músculos articulaciones, tendones o ligamentos
    - **Nociceptivo**: Aparece cuando hay daño o inflamación de un tejido (músculo, piel, hueso, órganos)
        - Ej: dolor por herida, golpe, inflamación
    - **Neuropático**: aparece cuando hay daño o alteración en los nervios que transmiten el dolor. Suele sentirse como ardor, electricidad, hormigueo o pinchazos.
        - Ej: dolor por neuropatía diabética.
    - **Mixto**
- ★ Según localización
    - **Somáticos**: suele estar bien localizado.
        - Ej: dolor por contractura.
    - **Visceral**: Suele ser difuso, profundo y difícil de localizar
        - Ej: dolor por cólicos intestinales

El modelo biomédico no explica:

- ★ La relación variable que existe entre la magnitud de la lesión y el dolor
- ★ Que estímulos no nociceptivos pueden producir dolor
- ★ La localización del olor y la lesión a veces es diferente
- ★ El dolor puede persistir una vez la lesión ya se ha curado
    - Cree en una mirada muy lineal causal.
- ★ La naturaleza del dolor y la localización puede cambiar a lo largo del tiempo.
- ★ El dolor es una experiencia multidimensional.
- ★ Ausencia de tratamientos adecuados para el dolor.
- ★ Limitaciones
    - Ignora factores psicológicos y sociales
    - Ignora y no aporta solución cuando no encuentra daño estructural
    - Prejuicios y maltrato contra los pacientes

Dolor definido biopsicosocialmente

Fenómeno **multicausal** en el que constituyen elementos fisiológicos, genéticos, biológicos, psicológicos, sociales e incluso homeostáticos (Craig, 2003)

- ★ Fenómeno complejo = Intensidad / causalidad / Transcurso en el tiempo / Significado personal
    - Todos estos fenómenos están intersectadas por lo bio-psico-social
- ★ Todo lo bio se desenvuelve en un contexto
- ★ No niega la predisposición genética ni los procesos centrales/periféricos biológicos.

Principales factores psicosociales del dolor

- ★ Variables cognitivas
  - Creencias
  - Estado de ánimo
  - Ansiedad y miedo
  - Espiritualidad
- ★ Variables comportamentales
  - Comportamientos de evitación
    - Últimamente, se ha promovido que se tiene que mover lo que duele (antes los duelos duraban mucho más por evitación).
  - Limitación de la actividad debido a ganancias secundarias
  - Afrontamiento
  - Suicidio
- ★ Variables ambientales
  - Familia
  - Cultura y etnia
  - Factores socioeconómicos
  - Trabajo

1. **Cognitivos: Patrones de pensamientos.. PPT**

- ★ Significado atribuido
  - Orgánicos
  - Psicológicos
- ★ Catastrofismo
  - Permean y modulan nuestra experiencia del dolor\
- ★ Ánimo
  - Depresión y dolor: circulo vicioso
    - Actividad
    - Uso de sernvicios médicos
- ★ Miedo y ansiedad ppt tabla
  - A mayor estrés, mayor dolor.
  - círculo vicioso
- ★ Espiritualidad
  - Fe, religión
  - Oración como método de afrontamiento
  - Facilita continuar con las actividades, pero no afecta la intensidad ni interferencia del dolor (los factores cognitivos modula la experiencia del dolor)

2. **Ambientales**

- ★ Familia
    - Interacciones sociales positivas como fuente de resiliencia (Sturgeon, et al. 2014)
    - Primera fuente de socialización: modelado y reforzamiento de conductas de dolor (Raichle et al., 2011)
    - Como la familia afronta el dolor permite visualizar cómo lo enfrenta uno mismo (se replican), es muy difícil que tengan métodos de afrontamiento distintos.
- ★ Cultura e Identidad étnica
- ★ Nivel socioeconómico
    - LIberacidad
    - Educación- habilidades cognitivas - estrategias de afrontamiento
- ★ Trabajo
    - Existe una relación entre preconceptos y representaciones, las cuales deben ser modificadas o transformadas para lograr un adecuado manejo del dolor crónico, esto aplica en los dominios del individuo afectado.
    - Las empresas que deben gestionar el problema al interior de sus propios procesos
    - Considerar como las modificaciones de estas representaciones transformaran los vínculos de accion (castillo & ballesteros, 2016)
        - Factores mecanismos
        - Factores sociales
            - Apoyo y satisfacción percibidos
            - Demandas laborales

3. Conductuales

- ★ Conducta evitativa
    - Función inicialmente protectora, pero mal adaptativa en el largo plazo (Asmundson et al., 2004)
    - Se perpetúan ciclos del dolor como los asociados a la depresión y ansiedad
    - Recuperar estado funcional anterior (obligar a que se arregle, que salga o haga cosas que antes le gustaban y hacían bien, antes de un cuadro depresivo)
- ★ Limitación de actividades como ganancia secundaria
    - Ganancia secundaria v/s malingering (hacerse el enfermo)
    - Importancia de no hacer juicio de valor, la evaluación de la ganancia secundaria se basa mediante el análisis funcional de la conducta (si es adaptativa o no, más allá de si está bien en la cultura o no)
- ★ Conductas de afrontamiento
    - Búsqueda de información
    - Uso de servicios de salud
    - Búsqueda de apoyo social

- Solución de problemas
- Mayor o menor uso de estrategias de distracción

★ Evitativo: Percepción y atención para distanciarse psicológicamente
- **Distracción:** agregar un estímulo adicional en el ambiente podría disminuir la intensidad del dolor percibido (ej: ver una serie)
- **Imaginería:** un contexto en el que se siente cómodo y a gusto para así distraer su atención del estímulo doloroso
- **Analgesia hipnótica:** Al alterar el estado de conciencia, se propicia un estado más sugestivo, haciendo de este modo que el cambio en la percepción del dolor sea más fácil.
- **Realidad virtual:** se desvía la atención de las sensaciones dolorosas por medio de la inmersión de los pacientes en un ambiente generado por un computador.

★ De aproximación
- ansiedad baja -> baja tensión muscular
- Aumento de la participación y el control
- Respiración diafragmática: ubicar una mano en el pecho y otra sobre el estómago (diafragma) y usando el feedback de movimiento percibido, guiar la respiración en tres tiempos: inhalación, exhalación y mantenimiento. (Park, Oh & Kim, 2013)
- Relajación muscular progresiva: Los músculos son secuencialmente tensados (10 segundos) y relajados (20 segundos) a lo largo del cuerpo (Jacobson, 1938)
- TCC - Catastrófico el dolor; expectativas de dolor se condicen con percepción del mismo, primero identificar el pensamiento, luego distracción/modificación del pensamiento - Revaluación dolor como un indicador de daño o dolor asociado al proceso de curación

★ Algunos factores pueden actuar como:
- Predisponentes: Ej catastrofismo
- Presidentes: Ej insomnio
- Agravantes: Ej estrusore ambientales
- Perpetuantes: Ej miedo, ansiedad y evitación

¿A quién le sirve que?

★ Principales basada en evidencia

★ Tratamientos deben ser multidisciplinario:
- Combinan fisioterapia, manejo al dolor, mediante analgesicos,e ducacun entregamiento ergoimicos como o mas de la siguientes terapias
  - Terapias cognitivas
  - …
- ppt

Psicoeducación en dolor

- ★ Que el paciente se vuelva experto en su dolor
- ★ Manejo realista de expectativas
- ★ En relación al mejo médico y educación farmacológica
    - Ej efectos secundarios

Biofeedback

- ★ Funciona para fomentar autorregulación, especialmente en cefaleas y tx temporomandibulares
- ★ Especialmente en encefalitis y tx temporomandibulares
- ★ Técnica que permite aprender a modificar la actividad fisiológica por medio de instrumentos de gran precisión, midiendo respuestas o actividades fisiológicas -> Esta información conjuntamente con los cambios producidos en el pensamiento, emociones y comportamiento, produce los cambios fisiológicos deseados, manteniéndose posteriormente sin la utilización continuada de ningún instrumento.
- ★ (Nestorio et al 2008; Medlicott y Harris, 2006)

Relajación

- ★ Relajación muscular
- ★ Relajación progresiva PPT

TCC

- ★ Reestructuración cognitiva. ppt hay un ejemplo
- ★ Automonitoreo y registro
- ★ Terapias basadas en… PPT

Exposición en vivo graduada

- ★
- ★ Etapas
    - PPT

Activación Conductual

- ★ ppt
- ★ Por medio de:
    - Automonitoreo de estado de ánimo y actividades
    - Programación de actividades
    - Estructuración de actividades

    - Resolución de problemas
        - Entrenamiento en habilidades sociales
        - Construcción de jerarquías
        - Modelado
        - Reforzamiento
        - PPT
        -

Aceptación y compromiso

- ★ Efectos medianos en intensidad de dolor, depresión, ansiedad, bienestar físico y calidad de vida.
- ★ La terapias basadas en la aceptación tiene efectos entre pequeño y medianos en la salud física y mental de los pacientes con dolor crónico, que son tan comparables a los que se encantan con las TCC
- ★ Tanto ACT como TCC mejoraron en la magnitud de la interferencia causada por el dolor, depresión y ansiedad relacionada con el dolor. Los pacientes que recibieron ACT reportaron mayor satisfacción que los que recibieron TCC

Otros

- ★ Arteterapia
- ★ Musicoterapia

Pero!!

- ★ Que tan adaptativo es en corto-largo plazo
- ★ No reforzar conductas gananciales
- ★ Ojo clínico
- ★ Recursos de los que se dispone

Terapia de Aceptación y Compromiso

La terapia de aceptación y compromiso (ACT) se define como un enfoque terapéutico que se centra en la promoción de la flexibilidad psicológica. Nos enfocamos en la relación del paciente con la relación con la problemática/sintomatología no en la veracidad de esta ni en su eliminación. En ese sentido, se busca una aceptación del mismo, y la búsqueda compromiso en acciones que se encuentren alineadas al sistema de creencias (valores) del paciente, reduciendo la evitación experiencial que estaría a la base de aspectos del malestar.

- ★ Flexibilidad cognitiva
    - Capacidad de contactar con el momento presente de forma plena y cambiar

hacia comportamientos en función de la situación exija en concordancia con los valores personales

- ★ **Lógica del modelo - Menos evitación experiencial - Más flexibilidad psicológica - Mayor calidad de vida.**
- ★ Objetivo: Promover la capacidad de
  - Estar en el presente
  - Aceptar experiencias internas
  - Actuar según valores
- ★ Compromiso + cambio conductual
  - Valores
    - Dirección de la vida significativa
  - Acción comprometida
    - Conductas guiadas por valores
- ★ Modelo de los Seis Proceso Básicos
  - El mapa conceptual de ACT e articula en torno a 6 procesos básicos
    1. Defusión cognitiva: ayuda a percibir los pensamientos como eventos mentales y no como verdades absolutas
       - Metapensamiento
       - "Soy super fracasado", se atribuye ese pensamiento como una parte de mí.
    2. Aceptación: promueven la apertura a emociones y pensamientos difíciles sin intentar evitarlos o suprimirlos
       - El cerebro no procesa la negación ("no te pongas nervioso" uno se pone nervioso y luego lo procesa para dejar de estarlo).
    3. Contacto con el momento presente: fomenta la conciencia plena del aquí y ahora
       - A Veces se piensa desde el déficit, en lo premórbido, pero hay que fijarse en quién soy yo hoy.
    4. Yo como contexto: permite a la persona comprender sus identidad más allá de su pensamientos o emociones actuales
       - Distancia entre ser el problema y ver el problema.
       - "No soy una persona útil" pensamiento de una persona postrada, se busca la distinción del pensamiento (cómo me siento ahora) a quién soy yo (mi identidad). No es lo mismo decir "soy inútil" a decir "ahora mismo, con las circunstancias no soy capaz de aportar el 100%"
       - Dejar el "Yo soy X" por "yo tengo X pensamiento" o "yo vivo una situación x".
    5. Identificación de valores: guía la conducta a partir de lo que realmente es importante en la vida
       - Darle sentido al proceso, pacientes que tuvieron que dejar

actividades que le movilizaban emociones. Hay que buscar el valor que los movilizaba y usarlo para el aquí y ahora (ej: subir el cerro, a partir del valor de la auto superación.) Hay que utilizar el valor si no se puede hacer la actividad

6. Acción comprometida : impulsa a tomar medidas concretas alineadas con los valores personales, incluso frente a dificultades emocionales
    - El 5 es la identificación que sostendrá este proceso de reparación y construcción de objetivos.

- No se trata de eliminar el malestar, sino flexibilizar la relación que el paciente tiene con el malestar/dolor.
    - Todos los pasos tienen que ocurrir, según el paciente se aborda tal punto. Se puede destinar menos tiempo a algún punto porque ya existe un avance, pero no se va a saltar el paso.

★ Act como fuerte evidencia en
- Dolor crónico
- Fibromialgia
- Enfermedades médicas crónicas

★ Objetivos en dolor
- Reducir discapacidad (no necesariamente ilor)
- Aumentar funcionamiento
- Mejorar calidad de vida
- Disminuir evitación

★ ACT en salud y dolor crónico
- Control del dolor: más sufrimiento
- Aceptación: mayor funcionamiento

Clase 06

10/09

Modelos Teóricos Comprensivos

★ Higienista o preventivo
- Surge en los años 60
- Apunta a condiciones higiénicas y sanitarias
- Mantener a la población saludable
- Su supuesto en mejoría de condiciones ambientales para prevenir
- *No busca cambiar las condiciones de la población, sino del ambiente*

★ Ecológico
- Urie Bronferbrenner, años 80
- Los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana vs condiciones de experimentación
- Desarrollo como una progresiva acomodación entre la persona y sus ambientes

- La familia, amigos, personal sanitario, organización hospitalaria y políticas gubernamentales son agentes que intervienen
- En los procesos de salud y enfermedad participan variables del mesosistema, exosistema y macrosistema.

★ Biopsicosocial
- George L. Engel 1977. Transformaciones en las enfermedades en la segunda mitad del siglo XX
- Personas como un sistemas complejos, en donde los procesos de salud y enfermedad involucran factores propios del contexto del individuo, a saber, estilo de vida familiar, nivel socioeconómico, acceso a la educación, hábitos saludables.
- Interacción del sistema social, psicológico y biológico → Abordaje interdisciplinario
- Acciones que promueven la

Modelos de Determinantes sociales

★ DS Modelo Material
- Las condiciones físicas de vida, como la vivienda, son el lugar donde el cuerpo entra en contacto con factores de riesgo para la salud:
  - Humo
  - Polvo
  - Bajas temperaturas
  - Lugares más vulnerables para accidentes
- Dichas condiciones físicas están al menos parcialmente determinadas por el ingreso económico.

★ DS Modelo Cultural / Conductual
- Bien cuestionable
- Existen significativas diferencias en conductas relacionadas a salud según NSE. A menos NSE mayor presencia de conductas de riesgo.
- **Explicación conductual directa:** (es cuestionable) Personas de menos NSE estarían dotados de algunas características de personalidad (inteligencia, resiliencia) que protegen de incurrir en conductas de riesgo para la salud
- **Explicación conductual-cultural:** Personas de menor NSE presentaron condiciones culturales específicas que los pondría en mayor riesgo de realizar conductas de riesgo.
- **Explicación educacion-cultural:** Personas mejor educadas darían mayor importancia al cuidado de la salud
- **Otras explicaciones culturales:** Necesidades de auto-regulación y feedback positivo del grupo, autocuidado como forma de distinción social/cultural

★ DS Modelo Psicosocial
- Relacionado a los efectos psicológicos de enfrentar condiciones de estrés en el hogar/trabajo y asociadas a la experiencia de bajo estatus social

    - Surge del poco convencimiento de algunos investigadores de que el modelo material individual explicase a cabalidad las diferencias en salidas encontradas en trabajadores de bajo vs alto estatus
    - Las experiencias estresantes de la vida (sociales por sobre física) ocasionan efectos orgánicos en los individuos que conllevan a mayor riesgo de enfermar.
    - Las inequidades en salud serían una consecuencia de las inequidades sociales y la respuesta al estrés estaría íntimamente relacionada con la posición socio-económica relativa de los individuos en dicha sociedad.
- ★ DS Modelo Curso de Vida
    - Más reciente, desde la década de los 90'
    - No surge solamente como un modelo nuevo, sino que aporta información valiosa para los demás modelos existentes
    - La posibilidad de tener una buena/mala salud en la adultez estaría fuertemente influenciada por las experiencias en la vida temprana y el curso de la vida

ESTO ENTRA EN EL CONTROL 👇

Modelos Teóricos Predictivos

En las últimas décadas se ha estudiado la relación entre el funcionamiento psicológico, la preservación de la salud y el desarrollo de distintas enfermedades.

Esto ha dado origen a la creación de distintos modelos de salud, con el fin de explicar y predecir los comportamientos de riesgo relacionados *(esto no es excluyente del modelo explicativo, sin embargo, el sujeto puede modificar el cuerpo o aparición de enfermedad con conductas propias de él).*

Modelo de la Autoeficacia

- ★ El ser humano puede aprender y cambiar su conducta **sin la necesidad de un reforzador ambiental**, usando la **observación** como método de aprendizaje al cual denominó **aprendizaje vicario**, se dio importancia para la adquisición de información y habilidades haciendo uso de las actividades cognitivas, denominándose variables personales.
- ★ **Autoeficacia** → Seguridad y confianza que tenemos en alcanzar el éxito que nos proponemos y depende del juicio que otorgamos a las capacidades o cualidades que tenemos. Nos programamos o mentalizamos según las expectativas de autoeficacia y el resultado de las conductas puede influir en el nivel de autoeficacia para futuras tareas.
- ★ Las creencias de las personas de que pueden producir los efectos deseados por sus acciones influyen las decisiones que toman, sus aspiraciones, el nivel de esfuerzo y perseverancia, la resistencia a la adversidad y la vulnerabilidad al estrés y a la depresión.
- ★ Se refiere a los juicios cognitivos y creencias de las personas sobre su capacidad para

realizar los comportamientos necesarios para la finalización exitosa de una tarea particular.

★ ”Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso”.

Variables del modelo de Autoeficacia

- ★ Evidencia previa:
  - consiste en la evaluación cognitiva de los éxitos y fracasos pasados del individuo frente a tareas análogas
- ★ Modelos de conducta:
  - El sujeto evalúa sus propias posibilidades a partir del desempeño de pares o modelos significativos
  - Aprendizaje vicario
- ★ Persuasión de Terceros
  - Juicios evaluativos, refuerzos verbales y expectativas comunicadas por personas significativas o figuras de autoridad
- ★ Evaluación de Estado
  - El organismo utiliza la activación somática (frecuencia cardiaca, sudoración, fatiga) y las reacciones emocionales (ansiedad, estrés, tranquilidad) como indicadores de competencia o vulnerabilidad.
  - Esto es en el momento, me di cuenta que lo estoy logrando y no tengo crisis de pánico y ahí retroalimento la percepción de mí misma sobre el rendimiento (“soy capaz”).

Esquema

Fuente de Creencia	Feedback	Patrones de conductas	Resultados
Evidencia previa Modelos de conducta	Alto “Sé que puedo hacerlo”	Ser activo → Oportunidades, controlar la situación, neutralizar obstáculos, planificar, practicar, perseverar, resolver creativamente los problemas, visualizar el éxito, limitar el estrés	Éxito
Persuasión de terceros Evaluación del estado	Bajo “No creo que pueda hacerlo”	Ser pasivo → Evitar las tareas difíciles, aspiraciones débiles,	Fracaso

		bajo compromiso, foco en déficit, desanimarse con los contratiempos, culpar a falta de habilidad o mala suerte, estrés, excusas del fracaso	

★ Resultados

- en el ejemplo de pedro (baja adherencia al tratamiento y mucho consumo de coca cola) compromiso poco (solo le interesa no hospitalizarse) habla devaluada mente de sí mismo y se desanima
- al revisar las 4 variables buscará en que intervenir.

Estudio sobre el Modelo de Autoeficacia (sobre la autoeficacia en el ejercicio en estudiantes universitarios de china)

★ Autoeficacia no es confianza abstracta (no es fe ni rasgo de personalidad) es específica del dominio (una creencia sobre un escenario específico)
  - Mide la eficacia a la iniciativa, orientarla a un dominio o actividad en específico
  - No es una buena autoimagen general, es una creencia de que puede hacerlo.

★ La autoeficacia tiene 4 variables, para lograr autoeficacia hacia el ejercicio, el estudiante necesita haber acumulado cierto dominio físico previo (evidencia previa) y un entorno que refuerce su competencia (producción de terceros)

Ventajas del Modelo de Autoeficacia:

★ Ofrece un marco claro y accionable para intervenir en diferentes contextos. Al identificar las cuatro fuentes de autoeficacia, permite diseñar estrategias concretas para mejorar el rendimiento y autoeficacia.

★ Supera el determinismo conductista al demostrar que las personas no solo reaccionan a estímulos o refuerzos externos, sino que regulan activamente su conducta a través de procesos cognitivos y la autoevaluación.

Desventajas del Modelo de Autoeficacia:

★ Al focalizarnos en las creencias internas del individuo, el modelo puede restar peso a factores socioeconómicos, limitaciones de recursos o barreras del entorno que influyen directa en el éxito o fracaso, independiente de cuenta confianza tenga la persona

★ La autoeficacia se considera un facilitador o mediador motivacional pero **nunca un predictor autosuficiente** ni una garantía de resultado por sí solo

Modelo Reducción de Riesgo

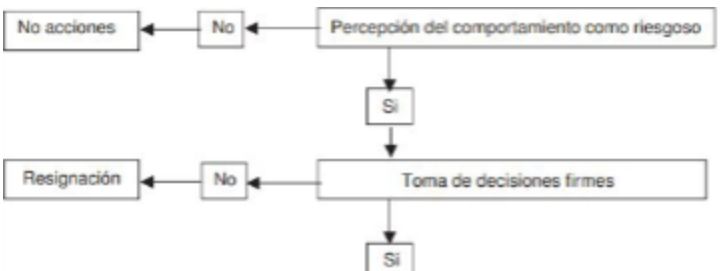
- ★ Este modelo parte de la idea de que existen comportamientos considerados como riesgosos que son difíciles o imposibles de cambiar. Fue diseñado para **atenuar** los comportamientos de riesgo y **disminuir** consecuencia
    - La autoeficacia de bandura influye en todos los modelos
- ★ Predecir conductas
    - Como no usar condón es un riesgo para contraer VIH
- ★ Reconoce habilidades
    - Como la autoeficacia de bandura
- ★ Incrementa la toma de conciencia
    - Parecido al modelo de creencias de salud, entiende como afecta sus idea a su salud
- ★ Disminuye conductas de riesgo.

Tres fases del modelo (variables información- severidad)

1. Percepción del Comportamiento como Riesgoso
    - Para percibir un comportamiento como peligrosos se necesitan 3 elementos
        - Información y conocimientos adecuados
        - Percibirse susceptibles al riesgo (estar dentro de un grupo de riesgo)
            - "no tendre VIH porque no soy un hombre homosexual"
        - Creer que padecer el daño es indeseable esto puede ser discordancia con el estigma, aprendizajes y/o conocimientos/ nociones sociales
2. Toma de Decisiones Firmes
    - Para tomar la decisión la persona se enfrenta a percepciones sobre los costos y beneficios de las conductas; además de sus propias creencias las de su entorno
        - Costos y Beneficios: Percepción sobre el posible cambio
            - Reacción de eficacia: percibir que el cambio conductual potencialmente me aleja del riesgo
            - Enjoyment: Debe buscarse un disfrute en la conducta alternativa (ej erotiza el condon)
        - **Autoeficacia percibida**: Creerme capaz de efectuar el cambio y no soy sometido por mi identidad "soy fumador"
        - Enjoyment/Disfrute: debe haber un disfrute en la conducta alternativa (ej: erotizar el condón)
        - Factores sociales normativos: Influyen en la relación costo-beneficio
3. Puesta en Acto (Enactment)
    - El objetivo de esta fase es que se empiecen a lograr los pasos para alcanzar la meta del cambio conductual, esto mediante 3 pasos separados para fines explicativos:

- Buscar información: académica, RRSS, amigos, familia, etc.
- Buscar ayuda, obtener remedios, help that helps: refiere a los estilos de ayuda y su jerarquización
    - Ej: Autoayuda, apoyo social informal, atención profesional o resignación.
- Establecer soluciones (Enacting Solutions): llevar al acto
- (Bonus) Normas sociales y Resolución de problemas: pasividad/actividad, medios formales/informales.

FASE I: Percepción de comportamiento como riesgoso	★ Información y conocimientos apropiados de la transmisión y prevención VIH ★ Percibirse susceptible de contraer VIH/SIDA ★ Creer que es indeseable contagiarse de VIH
FASE II: Toma de decisiones firmes	★ Reacción de eficacia ○ Percibir la eficacia del cambio ★ Autoeficacia percibida ○ Percepción de que uno puede establecer el cambio ★ Percepción placentera de la conducta ○ Agregando o eliminando de los repertorios conductuales ★ Factores sociales normativas ○ Percepciones de los grupos en los que el sujeto se desenvuelve y la influencia que tienen en su conducta
FASE III: Llevar a cabo el cambio de conducta	★ Buscar información ○ Tomar acciones en base en la búsqueda de ideas y opiniones para modificar la conducta ★ Obtener remedios ○ Varios estilos de ayuda que se adoptan ★ Establecer soluciones ○ Se asocian a variables como soporte social, el cambio en pareja, y habilidades de comunicación



Ventajas

- ★ Programas integrales comunitarios: cambio de conductas, actitudes, percepciones de riesgo, motivación, desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales.
- ★ Facilita la búsqueda de grupos sociales apoyo formales e informales y desarrollo de mecanismos efectivos de afrontamiento de las situaciones de estrés

Desventajas

- ★ Es necesario realizar ajustes en el modelo para que su aplicación arroje resultados positivos
- ★ Ajustes: tomar en cuenta los actos culturales y epidemiológicos
    - Ej: Usa v/s Africa

Ejemplo ensayo clínico de mujeres con una ITS no viral

- ★ Reconocer el riesgo: Se trabajaron conocimientos, percepción de vulnerabilidad, mitos y creencias sobre las ITS.
- ★ Comprometerse con el cambio: Se abordaron costos y barreras del cambio, relaciones de pareja, toma de decisiones y uso del condón.
- ★ Implementar el cambio: Se practicaron habilidades de comunicación, negociación y uso del condón mediante modelamiento y roleplay.
- ★ Contexto sociocultural: La intervención fue construida a partir de 18 meses de trabajo etnográfico, incluyendo 25 grupos focales, 102 entrevistas en profundidad y observaciones. Esto permitió identificar barreras culturales, relaciones de género, creencias y condiciones de vida de las participantes

1. Reconocimiento del riesgo
    - Identificación de la vulnerabilidad personal
    - Información sobre transmisión y consecuencias de las ITS
    - Trabajo sobre mitos y creencias
    - Identificación de conductas y parejas asociadas al riesgo
    - Relación entre la ITS actual y el riesgo futuro de VIH
2. Compromiso con el cambio
    - Prevención y tratamiento oportuno de ITS
    - Uso correcto del condón
    - Identificación de barreras para utilizarlo
    - Toma de decisiones
    - Trabajo sobre relaciones de pareja, confianza, conflicto y autoestima
    - Identificación de alternativas para reducir el riesgo
3. Adquisición de habilidades
    - Comunicación y negociación sexual
    - Práctica del uso del condón
    - Role playing
    - Desarrollo de autoeficacia para conversar sobre el condón

- Identificacion de situaciones que desencadenna sexo inseguro
- Establecimiento de metas
- Apoyo y vínculo entre las participantes

★ Resultado global: La intervención redujo significativamente las infecciones por gonorrea y clamidia durante los 12 meses de seguimiento

Modelo Transteórico o de Etapas del Cambio

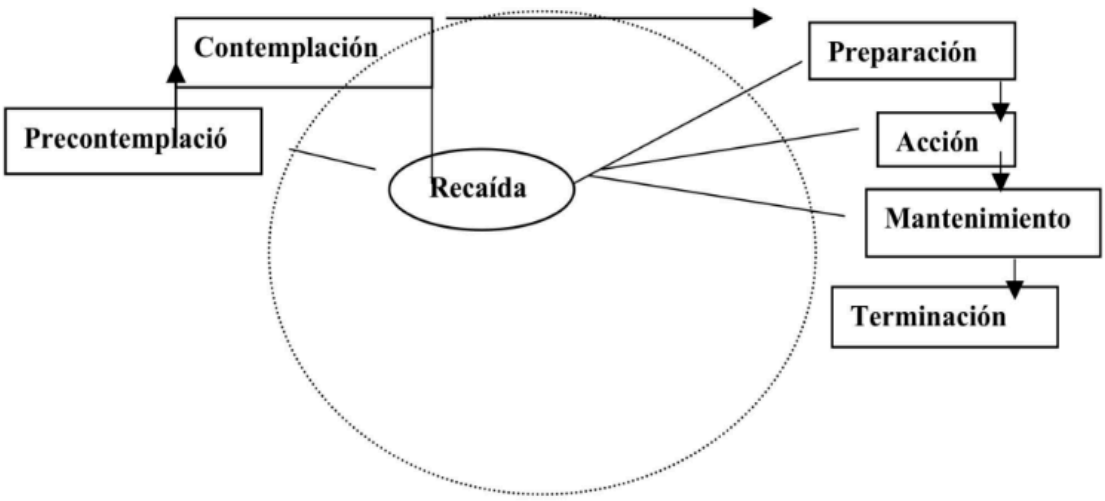
★ Modelo elaborado por James Prochaska
★ Se originó en la década de los 70' y se consolidó durante los años 90'
★ Comparacion de teorias para explicar cambios en el comportamiento de personas dependientes a la drogas y fumadores cigarros
★ Hoy, el MT es placa el cambio del comportamiento según 5 variables:
    - Etapas y procesos del cambio, balance decisorio, autoeficacia y tentación.
★ Este modelo es para conductas de difícil mdo icficaicon, como el consumo de drogas
★ busca intentar explicar el cambio a nivel conductual
★ Esquema general
★ Si una persona tiene una recaída no necesariamente tiene que empezar todo de nuevo, depende de la variable.
★ Recaída no es lo mismo a retroceso, solo volvemos a tener una conducta que habíamos dejado



Premisas del modelo

★ Los comportamientos están dominados de alguna manera por factores biológicos, sociales y de autocontrol
★ El cambio compartimientos es un proceso que se presenta con una secuencia de etapas
★ Todas las personas tienen niveles diversos de motivación y de intención de cambio
★ Las intervenciones deben ser hechas a la medida para cada paciente
★ Se necesitan estrategias específicas respecto a la etapa de cambios en la cual se encuentran cada individuo
★ Estar motivado para el cambio no es requisito para el éxito terapéutico
    - Porque esté motivado no es requisito para empezar
★ La mayoría de las personas en riesgo no se encuentran preparadas para el cambio y por lo tanto las intervenciones tradicionales no funcionan
★ Sin intervención las personas pueden quedarse en una etapa por mucho tiempo
★ Recaída es parte del proceso

Etapas de cambio



Componentes (variables) del modelo

1. Etapas de cambios: Describe el momento o disposición en que se encuentra la persona respecto de una conducta
    A. Precontemplación: no reconoce la necesidad de camion y no tiene intención de hacerlo
    B. Contemplación: Reconoce el problema y comienza a considerar el cambio, pero hay ambivalencia
    C. Preparación: tiene intención de cambiar y comienza a realizar pequeños pasos o planificar cosas
    D. Acción: está realizando cambios concretos en su conducta
    E. Mantenimiento: busca sostener el combo y prevenir recaídas
        a. Proceso largo
    F. Recaída: puede ocurrir un retorno parcial o total de la conducta anterior, se entiende como parte posible del proceso, no como un fracaso necesariamente.
2. Proceso del cambio:
    - Son las estrategias o mecanismos psicológicos y conductuales mediante los cuales la persona avanza de una etapa a otra
    - Idea central: las estrategias que resultan útiles dependen de la etapa en que se encuentre la persona.
    - Se suele dividir en:
        - Procesos Experienciales / Cognitivos
            - Aumento de conciencia (ayudaría en etapa a, b)
            - Reevaluación de sí mismo
            - Reevaluación ambiental (ayudaría en etapa a, b)

        - Liberación social
        - Activación emocional o vivencia de experiencias que movilizan el cambio
    - Procesos Conductuales
        - Autoliberación: compromiso con el cambio.
        - Contracondicionamiento: reemplazar una conducta por otra. (Etapa 3)
        - Control de estímulos: modificar situaciones que gatillan la conducta
        - Manejo de contingencia: utilizar consecuencias/recompensas para favorecer el cambio
        - Relaciones de ayuda: buscar apoyo social
3. Balance decisorio: se refiere a cómo la persona evalúa los costos y beneficios versus mantener la conducta actual. Implica dos dimensiones:
    a. "si cambio, ¿qué voy a ganar?": Costos y beneficios de no cambiar
    b. "si sigo igual, que obtengo o evito yo?"
    c. Por ejemplo, alguien que quiere dejar de fumar puede pensar que dejar de fumar mejorará mi salud pero fumar me ayuda a manejar el estrés y me cuesta imaginarme sin ese recurso.

       El balance decisivo es especialmente importante en la contemplación, porque **permite trabajar la ambivalencia** un lugar de intentar convencer a la persona de cambiar

4. Autoeficacia percibida: Es la confianza que tiene la persona en su capacidad para realizar y mantener el cambio, especialmente frente a situaciones difíciles o de riesgo
    a. No significa solamente "querer cambiar" sino pensar: "Aunque aparezcan dificultades, ¿Soy capaz de hacerlo?
    b. La autoeficacia puede variar según la situación. Una persona puede sentirse muy capaz en condiciones habituales, pero poco capaz frente al estrés, presión social o recaídas
    c. Por eso, el trabajo terapéutico busca aumentar experiencias de logro, estrategias de afrontamiento y percepción de control
5. Tentación: refleja la intensidad o urgencia experimentada por el individuo para realizar o practicar un comportamiento específico, particularmente en la presencia de factores o estímulos condicionantes o contextos emocionalmente complejos.

Ventajas

★ Considera el cambio como un proceso dinámico no literal
★ Permite adaptar la intervención al momento en que se encuentra la persona

Desventajas

- ★ Nivel de literacidad y algunas características sociodemográficas limiten el impacto de las intervenciones
- ★ Con conductas asociadas a contextos socioculturales es importante examinar otras variables más amplias del contexto

Ejemplo Psicoterapia en mujeres victimas de violencia de pareja

- ★ Situación ambivalente (no querer salir sabiendo el daño)
- ★ Precontemplación
    - Aceptar existencia de maltrato; aceptable, poco problemático o inevitable; no es pasividad, esfuerzo en cambio de pareja.
    - Inducir la duda; psicoeducar explícitamente, explorar al detalle, conectar maltrato con pérdida de salud, ciclo de la violencia.
- ★ Contemplación
    - Cambios en la conducta propia, mayor autonomía, cuestionar la posibilidad de cambio, se cuestiona lealtad
    - Analizar obstáculos, buscar redes (equipo), Agentes/instituciones, expectativas y objetivos, explorar idea de cambio de pareja
- ★ Preparación
    - Fase de decisión de cambiar la relación
- ★ Acción y Mantención
    - 3 fases
        - A pesar de cambios, la violencia se mantiene
        - Desaparición de abuso
        - Proseguir reconstrucción vital

Modelo de Creencias en Salud

- ★ Desarrollado en la década del 50’
- ★ Hochbaum, Rosenstock & Kegels
- ★ Ha sido el MT sistemáticamente más usado y estudiado para explicar acciones de prevención de enfermedades, respuestas a síntomas y a enfermedades, así como otros diversos patrones comportamentales con efectos en salud
- ★ Ha sido utilizado para explicar porqué los individuos no utilizan los servicios preventivos de salud y porque adhieren o no al tratamiento

Supuestos del Modelo de Creencias en Salud

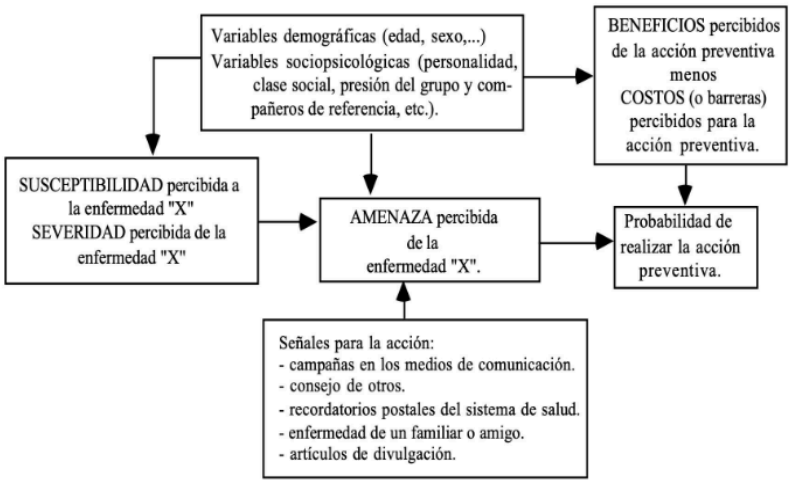
- ★ Un individuo llevará a cabo una conducta si:
    - Están en un estado psicológico preparatorio para llevar a cabo la acción
    - Si una conducta determinada puede lleva a reducir una amenaza

- ★ Las conductas de los individuos estarán determinadas por el deseo de evitar una enfermedad y el conocimiento de que existen conductas que pueden ayudar a aliviar o prevenir enfermedades
- ★ Exitoso para preceder conductas únicas (one shot behaviors), por ejemplo, mamografías. Es un modelo simple que ha servido de base para desarrollar otros modelos, donde la susceptibilidad es un componente clave

Componentes del Modelo

- ★ **Susceptibilidad percibida:** Percepción subjetiva de riegos de contra una determinada condición e incluye aceptar diagnóstico y valorar personalmente nuevas valoraciones de nuevas susceptibilidades
- ★ **Severidad percibida**: Percepción respecto a las consecuencias asociadas con haber contraído una enfermedad determinada o por no tratar una enfermedad o condición X, incluye consecuencias sociales y médicas.
- ★ **Amenaza percibida:** combinación de percepción de susceptibilidad y severidad, un aspecto clave para la prevención, por ejemplo, es que el individuo crea que también para detener la enfermedad a pesar de la ausencia de síntoma
- ★ **Beneficios percibidos:** la decisión de seguir un tratamiento dependerá de las creencias respecto la efectividad de un tratamiento determinado
- ★ **Costos (o barreras) percibidas:** aspectos negativos potenciales de una conducta particular que actúan como impedimentos para llevar a cabo esta concua
- ★ **Señales para la acción:** Situaciones, eventos, etc. que son gatillantes para la acción. Ej: consejos familiares o de amigos, campañas masivas, experiencias personales con la enfermedad.
- ★ **Probabilidad de cambio:** Probabilidad de que un individuo lleve a cabo un cambio conductual

Estructura del modelo



Ventajas

- ★ Ha sido utilizado para explicar porqué individuos no utilizan servicios preventivos en salud y porque adhieren o no a tratamientos médicos
- ★ Muestra la importancia de sesgos en percepción de riesgo para levar a cabo ciertas conductas e salud

Desventajas

- ★ El modelo ha sido capaz de demostrar varianzas en el comportamiento, aunque muestra limitaciones para describir el proceso de cómo esto ocurre
- ★ No define objetivos más específicos en términos de grupos de población y tópicos de interés en salud

4 Preguntas del control (una de cada modelo)

1. **¿Qué propone el modelo?**
2. **Explique sus variables brevemente**
3. **Usted invente una intervención:**
    a. Problemas, sesiones, tareas, resultados, variables.
    b. Para esta perosna de salud diabete “en 3 sesiones me propongo hacer XX tareas“
    c. Media plana
    d. La intervención puede tocar o el de creencias de salud o el de autoeficacia.

    Los ejemplos de los modelos sirven para pensar en la pregunta de intervención

4. **1 Ventaja y 1 Desventaja**

Control

Preguntas del control (una de cada modelo)

1. ¿Qué propone el modelo?
2. Explique sus variables brevemente
3. Usted invente una intervención:
    a. Problemas, sesiones, tareas, resultados, variables.
    b. Para esta perosna de salud diabete “en 3 sesiones me propongo hacer XX tareas“
    c. Media plana
    d. La intervención puede tocar o el de creencias de salud o el de autoeficacia.

    Los ejemplos de los modelos sirven para pensar en la pregunta de intervención

4. 1 Ventaja y 1 Desventaja

ESTO ENTRA EN EL CONTROL 👇

Modelos Teóricos Predictivos

En las últimas décadas se ha estudiado la relación entre el funcionamiento psicológico, la preservación de la salud y el desarrollo de distintas enfermedades.

Esto ha dado origen a la creación de distintos modelos de salud, con el fin de explicar y predecir los comportamientos de riesgo relacionados *(esto no es excluyente del modelo explicativo, sin embargo, el sujeto puede modificar el cuerpo o aparición de enfermedad con conductas propias de él).*

Modelo de la Autoeficacia

- ★ El ser humano puede aprender y cambiar su conducta **sin la necesidad de un reforzador ambiental**, usando la **observación** como método de aprendizaje al cual denominó **aprendizaje vicario**, se dio importancia para la adquisición de información y habilidades haciendo uso de las actividades cognitivas, denominándose variables personales.
- ★ **Autoeficacia** → Seguridad y confianza que tenemos en alcanzar el éxito que nos proponemos y depende del juicio que otorgamos a las capacidades o cualidades que tenemos. Nos programamos o mentalizamos según las expectativas de autoeficacia y el resultado de las conductas puede influir en el nivel de autoeficacia para futuras tareas.
- ★ Las creencias de las personas de que pueden producir los efectos deseados por sus acciones influyen las decisiones que toman, sus aspiraciones, el nivel de esfuerzo y perseverancia, la resistencia a la adversidad y la vulnerabilidad al estrés y a la depresión.
- ★ Se refiere a los juicios cognitivos y creencias de las personas sobre su capacidad para realizar los comportamientos necesarios para la finalización exitosa de una tarea particular.
- ★ ”Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso”.

Variables del modelo de Autoeficacia

- ★ Evidencia previa:
  - consiste en la evaluación cognitiva de los éxitos y fracasos pasados del individuo frente a tareas análogas
- ★ Modelos de conducta:
  - El sujeto evalúa sus propias posibilidades a partir del desempeño de pares o modelos significativos
  - Aprendizaje vicario
- ★ Persuasión de Terceros
  - Juicios evaluativos, refuerzos verbales y expectativas comunicadas por personas

significativas o figuras de autoridad

★ Evaluación de Estado
  - El organismo utiliza la activación somática (frecuencia cardiaca, sudoración, fatiga) y las reacciones emocionales (ansiedad, estrés, tranquilidad) como indicadores de competencia o vulnerabilidad.
  - Esto es en el momento, me di cuenta que lo estoy logrando y no tengo crisis de pánico y ahí retroalimento la percepción de mí misma sobre el rendimiento (“soy capaz”).

Esquema

Fuente de Creencia	Feedback	Patrones de conductas	Resultados
Evidencia previa Modelos de conducta	Alto “Sé que puedo hacerlo”	Ser activo → Oportunidades, controlar la situación, neutralizar obstáculos, planificar, practicar, perseverar, resolver creativamente los problemas, visualizar el éxito, limitar el estrés	Éxito
Persuasión de terceros Evaluación del estado	Bajo “No creo que pueda hacerlo”	Ser pasivo → Evitar las tareas difíciles, aspiraciones débiles, bajo compromiso, foco en déficit, desanimarse con los contratiempos, culpar a falta de habilidad o mala suerte, estrés, excusas del fracaso	Fracaso

★ Resultados

- en el ejemplo de pedro (baja adherencia al tratamiento y mucho consumo de coca cola) compromiso poco (solo le interesa no hospitalizarse) habla devaluada mente de sí mismo y se desanima
- al revisar las 4 variables buscará en que intervenir.

Estudio sobre el Modelo de Autoeficacia (sobre la autoeficacia en el ejercicio en estudiantes

universitarios de china)

- ★ Autoeficacia no es confianza abstracta (no es fe ni rasgo de personalidad) es específica del dominio (una creencia sobre un escenario específico)
    - Mide la eficacia a la iniciativa, orientarla a un dominio o actividad en específico
    - No es una buena autoimagen general, es una creencia de que puede hacerlo.
- ★ La autoeficacia tiene 4 variables, para lograr autoeficacia hacia el ejercicio, el estudiante necesita haber acumulado cierto dominio físico previo (evidencia previa) y un entorno que refuerce su competencia (producción de terceros)

Ventajas del Modelo de Autoeficacia:

- ★ Ofrece un marco claro y accionable para intervenir en diferentes contextos. Al identificar las cuatro fuentes de autoeficacia, permite diseñar estrategias concretas para mejorar el rendimiento y autoeficacia.
- ★ Supera el determinismo conductista al demostrar que las personas no solo reaccionan a estímulos o refuerzos externos, sino que regulan activamente su conducta a través de procesos cognitivos y la autoevaluación.

Desventajas del Modelo de Autoeficacia:

- ★ Al focalizarnos en las creencias internas del individuo, el modelo puede restar peso a factores socioeconómicos, limitaciones de recursos o barreras del entorno que influyen directa en el éxito o fracaso, independiente de cuenta confianza tenga la persona
- ★ La autoeficacia se considera un facilitador o mediador motivacional pero **nunca un predictor autosuficiente** ni una garantía de resultado por sí solo

Modelo Reducción de Riesgo

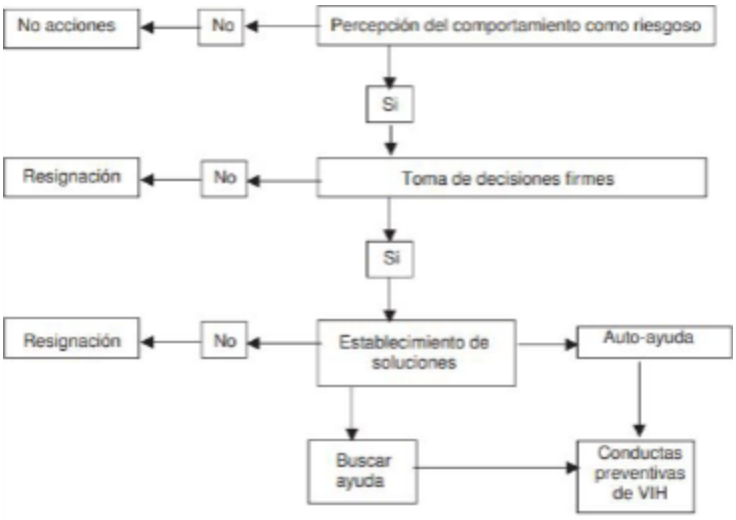
- ★ Este modelo parte de la idea de que existen comportamientos considerados como riesgosos que son difíciles o imposibles de cambiar. Fue diseñado para **atenuar** los comportamientos de riesgo y **disminuir** consecuencia
    - La autoeficacia de bandura influye en todos los modelos
- ★ Predecir conductas
    - Como no usar condón es un riesgo para contraer VIH
- ★ Reconoce habilidades
    - Como la autoeficacia de bandura
- ★ Incrementa la toma de conciencia
    - Parecido al modelo de creencias de salud, entiende como afecta sus idea a su salud
- ★ Disminuye conductas de riesgo.

Tres fases del modelo (variables información- severidad)

1. Percepción del Comportamiento como Riesgoso
    - Para percibir un comportamiento como peligrosos se necesitan 3 elementos
        - Información y conocimientos adecuados
        - Percibirse susceptibles al riesgo (estar dentro de un grupo de riesgo)
            - "no tendre VIH porque no soy un hombre homosexual"
        - Creer que padecer el daño es indeseable esto puede ser discordancia con el estigma, aprendizajes y/o conocimientos/ nociones sociales
2. Toma de Decisiones Firmes
    - Para tomar la decisión la persona se enfrenta a percepciones sobre los costos y beneficios de las conductas; además de sus propias creencias las de su entorno
        - Costos y Beneficios: Percepción sobre el posible cambio
            - Reacción de eficacia: percibir que el cambio conductual potencialmente me aleja del riesgo
            - Enjoyment: Debe buscarse un disfrute en la conducta alternativa (ej erotiza el condon)
        - **Autoeficacia percibida**: Creerme capaz de efectuar el cambio y no soy sometido por mi identidad "soy fumador"
        - Enjoyment/Disfrute: debe haber un disfrute en la conducta alternativa (ej: erotizar el condón)
        - Factores sociales normativos: Influyen en la relación costo-beneficio
3. Puesta en Acto (Enactment)
    - El objetivo de esta fase es que se empiecen a lograr los pasos para alcanzar la meta del cambio conductual, esto mediante 3 pasos separados para fines explicativos:
        - Buscar información: académica, RRSS, amigos, familia, etc.
        - Buscar ayuda, obtener remedios, help that helps: refiere a los estilos de ayuda y su jerarquización
            - Ej: Autoayuda, apoyo social informal, atención profesional o resignación.
        - Establecer soluciones (Enacting Solutions): llevar al acto
        - (Bonus) Normas sociales y Resolución de problemas: pasividad/actividad, medios formales/informales.

FASE I: Percepción de comportamiento como riesgoso	★ Información y conocimientos apropiados de la transmisión y prevención VIH ★ Percibirse susceptible de contraer VIH/SIDA ★ Creer que es indeseable contagiarse de VIH

FASE II: Toma de decisiones firmes	★ Reacción de eficacia ○ Percibir la eficacia del cambio ★ Autoeficacia percibida ○ Percepción de que uno puede establecer el cambio ★ Percepción placentera de la conducta ○ Agregando o eliminando de los repertorios conductuales ★ Factores sociales normativas ○ Percepciones de los grupos en los que el sujeto se desenvuelve y la influencia que tienen en su conducta
FASE III: Llevar a cabo el cambio de conducta	★ Buscar información ○ Tomar acciones en base en la búsqueda de ideas y opiniones para modificar la conducta ★ Obtener remedios ○ Varios estilos de ayuda que se adoptan ★ Establecer soluciones ○ Se asocian a variables como soporte social, el cambio en pareja, y habilidades de comunicación



Ventajas

★ Programas integrales comunitarios: cambio de conductas, actitudes, percepciones de riesgo, motivación, desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales.

★ Facilita la búsqueda de grupos sociales apoyo formales e informales y desarrollo de mecanismos efectivos de afrontamiento de las situaciones de estrés

Desventajas

- ★ Es necesario realizar ajustes en el modelo para que su aplicación arroje resultados positivos
- ★ Ajustes: tomar en cuenta los actos culturales y epidemiológicos
    - Ej: Usa v/s Africa

Ejemplo ensayo clínico de mujeres con una ITS no viral

- ★ Reconocer el riesgo: Se trabajaron conocimientos, percepción de vulnerabilidad, mitos y creencias sobre las ITS.
- ★ Comprometerse con el cambio: Se abordaron costos y barreras del cambio, relaciones de pareja, toma de decisiones y uso del condón.
- ★ Implementar el cambio: Se practicaron habilidades de comunicación, negociación y uso del condón mediante modelamiento y roleplay.
- ★ Contexto sociocultural: La intervención fue construida a partir de 18 meses de trabajo etnográfico, incluyendo 25 grupos focales, 102 entrevistas en profundidad y observaciones. Esto permitió identificar barreras culturales, relaciones de género, creencias y condiciones de vida de las participantes

1. Reconocimiento del riesgo
    - Identificación de la vulnerabilidad personal
    - Información sobre transmisión y consecuencias de las ITS
    - Trabajo sobre mitos y creencias
    - Identificación de conductas y parejas asociadas al riesgo
    - Relación entre la ITS actual y el riesgo futuro de VIH
2. Compromiso con el cambio
    - Prevención y tratamiento oportuno de ITS
    - Uso correcto del condón
    - Identificación de barreras para utilizarlo
    - Toma de decisiones
    - Trabajo sobre relaciones de pareja, confianza, conflicto y autoestima
    - Identificación de alternativas para reducir el riesgo
3. Adquisición de habilidades
    - Comunicación y negociación sexual
    - Práctica del uso del condón
    - Role playing
    - Desarrollo de autoeficacia para conversar sobre el condón
    - Identificacion de situaciones que desencadenna sexo inseguro
    - Establecimiento de metas
    - Apoyo y vínculo entre las participantes

- ★ Resultado global: La intervención redujo significativamente las infecciones por gonorrea y clamidia durante los 12 meses de seguimiento

Modelo Transteórico o de Etapas del Cambio

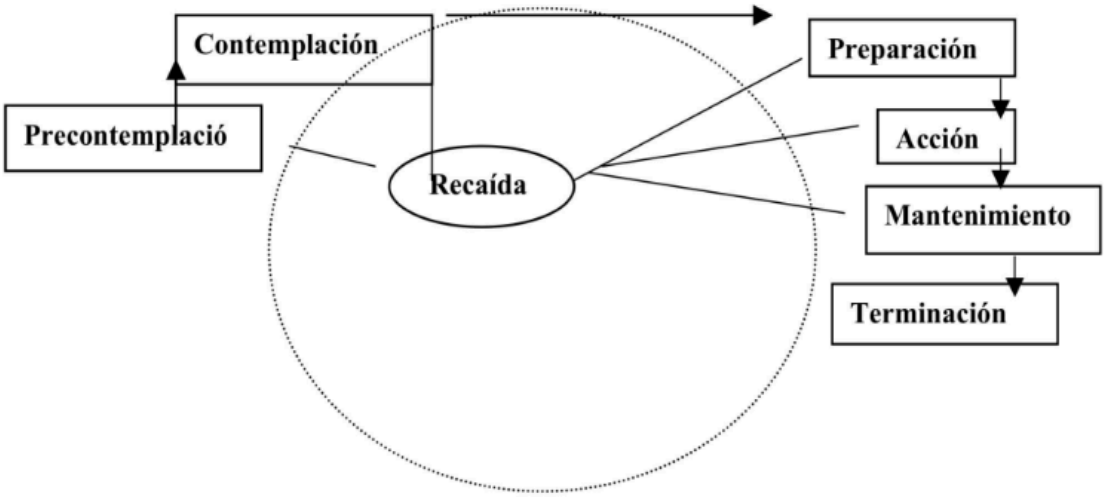
- ★ Modelo elaborado por James Prochaska
- ★ Se originó en la década de los 70' y se consolidó durante los años 90'
- ★ Comparacion de teorias para explicar cambios en el comportamiento de personas dependientes a la drogas y fumadores cigarros
- ★ Hoy, el MT es placa el cambio del comportamiento según 5 variables:
    - Etapas y procesos del cambio, balance decisorio, autoeficacia y tentación.
- ★ Este modelo es para conductas de difícil mdo icficaicon, como el consumo de drogas
- ★ busca intentar explicar el cambio a nivel conductual
- ★ Esquema general
- ★ Si una persona tiene una recaída no necesariamente tiene que empezar todo de nuevo, depende de la variable.
- ★ Recaída no es lo mismo a retroceso, solo volvemos a tener una conducta que habíamos dejado



Premisas del modelo

- ★ Los comportamientos están dominados de alguna manera por factores biológicos, sociales y de autocontrol
- ★ El cambio compartimientos es un proceso que se presenta con una secuencia de etapas
- ★ Todas las personas tienen niveles diversos de motivación y de intención de cambio
- ★ Las intervenciones deben ser hechas a la medida para cada paciente
- ★ Se necesitan estrategias específicas respecto a la etapa de cambios en la cual se encuentran cada individuo
- ★ Estar motivado para el cambio no es requisito para el éxito terapéutico
    - Porque esté motivado no es requisito para empezar
- ★ La mayoría de las personas en riesgo no se encuentran preparadas para el cambio y por lo tanto las intervenciones tradicionales no funcionan
- ★ Sin intervención las personas pueden quedarse en una etapa por mucho tiempo
- ★ Recaída es parte del proceso

Etapas de cambio



Componentes (variables) del modelo

1. Etapas de cambios: Describe el momento o disposición en que se encuentra la persona respecto de una conducta
    A. Precontemplación: no reconoce la necesidad de camion y no tiene intención de hacerlo
    B. Contemplación: Reconoce el problema y comienza a considerar el cambio, pero hay ambivalencia
    C. Preparación: tiene intención de cambiar y comienza a realizar pequeños pasos o planificar cosas
    D. Acción: está realizando cambios concretos en su conducta
    E. Mantenimiento: busca sostener el combo y prevenir recaídas
        a. Proceso largo
    F. Recaída: puede ocurrir un retorno parcial o total de la conducta anterior, se entiende como parte posible del proceso, no como un fracaso necesariamente.
2. Proceso del cambio:
    - Son las estrategias o mecanismos psicológicos y conductuales mediante los cuales la persona avanza de una etapa a otra
    - Idea central: las estrategias que resultan útiles dependen de la etapa en que se encuentre la persona.
    - Se suele dividir en:
        - Procesos Experienciales / Cognitivos
            - Aumento de conciencia (ayudaría en etapa a, b)
            - Reevaluación de sí mismo
            - Reevaluación ambiental (ayudaría en etapa a, b)
            - Liberación social
            - Activación emocional o vivencia de experiencias que movilizan el

cambio

- Procesos Conductuales
  - Autoliberación: compromiso con el cambio.
  - Contracondicionamiento: reemplazar una conducta por otra. (Etapa 3)
  - Control de estímulos: modificar situaciones que gatillan la conducta
  - Manejo de contingencia: utilizar consecuencias/recompensas para favorecer el cambio
  - Relaciones de ayuda: buscar apoyo social

3. Balance decisorio: se refiere a cómo la persona evalúa los costos y beneficios versus mantener la conducta actual. Implica dos dimensiones:
   a. "si cambio, ¿qué voy a ganar?": Costos y beneficios de no cambiar
   b. "si sigo igual, que obtengo o evito yo?"
   c. Por ejemplo, alguien que quiere dejar de fumar puede pensar que dejar de fumar mejorará mi salud pero fumar me ayuda a manejar el estrés y me cuesta imaginarme sin ese recurso.

      El balance decisivo es especialmente importante en la contemplación, porque **permite trabajar la ambivalencia** un lugar de intentar convencer a la persona de cambiar

4. Autoeficacia percibida: Es la confianza que tiene la persona en su capacidad para realizar y mantener el cambio, especialmente frente a situaciones difíciles o de riesgo
   a. No significa solamente "querer cambiar" sino pensar: "Aunque aparezcan dificultades, ¿Soy capaz de hacerlo?
   b. La autoeficacia puede variar según la situación. Una persona puede sentirse muy capaz en condiciones habituales, pero poco capaz frente al estrés, presión social o recaídas
   c. Por eso, el trabajo terapéutico busca aumentar experiencias de logro, estrategias de afrontamiento y percepción de control
5. Tentación: refleja la intensidad o urgencia experimentada por el individuo para realizar o practicar un comportamiento específico, particularmente en la presencia de factores o estímulos condicionantes o contextos emocionalmente complejos.

Ventajas

- ★ Considera el cambio como un proceso dinámico no literal
- ★ Permite adaptar la intervención al momento en que se encuentra la persona

Desventajas

- ★ Nivel de literacidad y algunas características sociodemográficas limiten el impacto de

las intervenciones
- ★ Con conductas asociadas a contextos socioculturales es importante examinar otras variables más amplias del contexto

Ejemplo Psicoterapia en mujeres victimas de violencia de pareja

- ★ Situación ambivalente (no querer salir sabiendo el daño)
- ★ Precontemplación
    - Aceptar existencia de maltrato; aceptable, poco problemático o inevitable; no es pasividad, esfuerzo en cambio de pareja.
    - Inducir la duda; psicoeducar explícitamente, explorar al detalle, conectar maltrato con pérdida de salud, ciclo de la violencia.
- ★ Contemplación
    - Cambios en la conducta propia, mayor autonomía, cuestionar la posibilidad de cambio, se cuestiona lealtad
    - Analizar obstáculos, buscar redes (equipo), Agentes/instituciones, expectativas y objetivos, explorar idea de cambio de pareja
- ★ Preparación
    - Fase de decisión de cambiar la relación
- ★ Acción y Mantención
    - 3 fases
        - A pesar de cambios, la violencia se mantiene
        - Desaparición de abuso
        - Proseguir reconstrucción vital

Modelo de Creencias en Salud

- ★ Desarrollado en la década del 50’
- ★ Hochbaum, Rosenstock & Kegels
- ★ Ha sido el MT sistemáticamente más usado y estudiado para explicar acciones de prevención de enfermedades, respuestas a síntomas y a enfermedades, así como otros diversos patrones comportamentales con efectos en salud
- ★ Ha sido utilizado para explicar porqué los individuos no utilizan los servicios preventivos de salud y porque adhieren o no al tratamiento

Supuestos del Modelo de Creencias en Salud

- ★ Un individuo llevará a cabo una conducta si:
    - Están en un estado psicológico preparatorio para llevar a cabo la acción
    - Si una conducta determinada puede lleva a reducir una amenaza
- ★ Las conductas de los individuos estarán determinadas por el deseo de evitar una

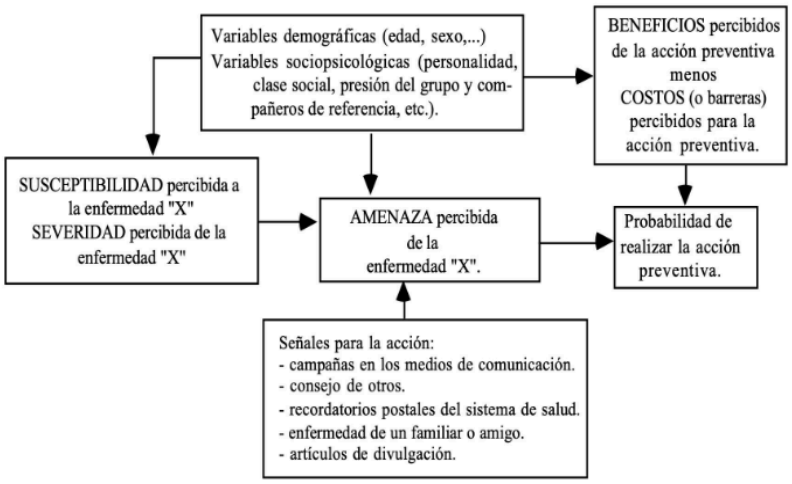
enfermedad y el conocimiento de que existen conductas que pueden ayudar a aliviar o prevenir enfermedades

- ★ Exitoso para preceder conductas únicas (one shot behaviors), por ejemplo, mamografías. Es un modelo simple que ha servido de base para desarrollar otros modelos, donde la susceptibilidad es un componente clave

Componentes del Modelo

- ★ **Susceptibilidad percibida:** Percepción subjetiva de riegos de contra una determinada condición e incluye aceptar diagnóstico y valorar personalmente nuevas valoraciones de nuevas susceptibilidades
- ★ **Severidad percibida**: Percepción respecto a las consecuencias asociadas con haber contraído una enfermedad determinada o por no tratar una enfermedad o condición X, incluye consecuencias sociales y médicas.
- ★ **Amenaza percibida:** combinación de percepción de susceptibilidad y severidad, un aspecto clave para la prevención, por ejemplo, es que el individuo crea que también para detener la enfermedad a pesar de la ausencia de síntoma
- ★ **Beneficios percibidos:** la decisión de seguir un tratamiento dependerá de las creencias respecto la efectividad de un tratamiento determinado
- ★ **Costos (o barreras) percibidas:** aspectos negativos potenciales de una conducta particular que actúan como impedimentos para llevar a cabo esta concua
- ★ **Señales para la acción:** Situaciones, eventos, etc. que son gatillantes para la acción. Ej: consejos familiares o de amigos, campañas masivas, experiencias personales con la enfermedad.
- ★ **Probabilidad de cambio:** Probabilidad de que un individuo lleve a cabo un cambio conductual

Estructura del modelo



Ventajas

- ★ Ha sido utilizado para explicar porqué individuos no utilizan servicios preventivos en salud y porque adhieren o no a tratamientos médicos
- ★ Muestra la importancia de sesgos en percepción de riesgo para levar a cabo ciertas conductas e salud

Desventajas

- ★ El modelo ha sido capaz de demostrar varianzas en el comportamiento, aunque muestra limitaciones para describir el proceso de cómo esto ocurre
- ★ No define objetivos más específicos en términos de grupos de población y tópicos de interés en salud

4 Preguntas del control (una de cada modelo)

1. **¿Qué propone el modelo?**
2. **Explique sus variables brevemente**
3. **Usted invente una intervención:**
    a. Problemas, sesiones, tareas, resultados, variables.
    b. Para esta perosna de salud diabete “en 3 sesiones me propongo hacer XX tareas“
    c. Media plana
    d. La intervención puede tocar o el de creencias de salud o el de autoeficacia.

    Los ejemplos de los modelos sirven para pensar en la pregunta de intervención

4. **1 Ventaja y 1 Desventaja**